

PSIQUIATRIA SOMATOPSÍQUICA®

MANUAL DO APLICADOR IPS®

“Este documento será a bíblia da formação.”

Dra. Renata Guerra

Princípios da Psiquiatria Somatopsíquica

Princípio da Preparação Somatopsíquica

A efetividade das intervenções para mudança de comportamento depende da existência prévia de condições internas que permitam ao indivíduo perceber, interpretar e utilizar seus estados corporais e emocionais como base para escolhas conscientes. Assim, a intervenção não deve começar pela mobilização da motivação, mas pelo desenvolvimento da consciência corporal, da presença e da agência, a fim de ser elemento facilitador para desenvolver a capacidade de autorregulação necessária para que a motivação deixe de ser o principal determinante do comportamento.

Princípio da Prontidão Somatopsíquica

A mudança sustentável do comportamento não depende prioritariamente do aumento da motivação, mas do desenvolvimento progressivo de condições internas que permitam ao indivíduo perceber, compreender e utilizar sua experiência corporal como base para escolhas conscientes. Quando essas condições ainda não estão presentes, intervenções centradas exclusivamente na motivação ou na prescrição comportamental podem produzir baixa adesão, sofrimento ou sensação de fracasso.

A IPS propõe que a motivação, embora relevante, não é suficiente para explicar nem sustentar a mudança comportamental. Ela depende de condições internas prévias — consciência corporal, presença e agência — que permitem que a intenção seja transformada em ação consistente.

Estrutura-Mãe da Psiquiatria Somatopsíquica

1. Teoria

- Artigo Frontiers (2025)
- Artigo Geopsychiatry (2026)
- Modelo de Corporificação

2. Método

- 4 pilares
- 7 passos
- CORAGEM®

3. Avaliação

- MAIA
- FFMQ
- GSES
- Escala de Corporificação IPS®

4. Tecnologia Clínica

- Dashboard IPS®
- Relatório Evolutivo IPS®
- Índice de Integração Somatopsíquica (IIS®)

5. Formação

- Formação Essencial IPS®
- Aplicador Clínico IPS®

6. Pesquisa

- Banco de Dados IPS®
- Validação da Escala IPS
- Estudos de efetividade

Sumário do Manual do Aplicador IPS®

PARTE I — FUNDAMENTOS

Capítulo 1 — História da Psiquiatria Somatopsíquica

Capítulo 2 — A grande tese da IPS

Capítulo 3 — Corpo, mente e comportamento

Capítulo 4 — Corporificação: o mecanismo da mudança sustentável

PARTE II — O MÉTODO

Capítulo 5 — Os 4 pilares

Capítulo 6 — Os 7 passos

Capítulo 7 — CORAGEM®

PARTE III — AVALIAÇÃO

Capítulo 8 — MAIA-2

Capítulo 9 — FFMQ

Capítulo 10 — GSES

Capítulo 11 — Escala IPS

PARTE IV — APLICAÇÃO CLÍNICA

Capítulo 12 — Consulta individual

Capítulo 13 — Grupos terapêuticos

Capítulo 14 — Indicações e contraindicações

PARTE V — INTEGRAÇÃO E MUDANÇA

Capítulo 15 — Mudança de hábitos e Medicina do Estilo de Vida

CAPÍTULO 1

História da Psiquiatria Somatopsíquica

Do conhecimento à transformação: a busca por uma psiquiatria mais integrada

A prática clínica em psiquiatria frequentemente confronta o profissional com uma situação aparentemente paradoxal. Muitos pacientes compreendem claramente o que precisam fazer para melhorar sua saúde física e mental. Sabem que deveriam dormir melhor, alimentar-se de forma mais saudável, praticar atividade física regularmente, cultivar relacionamentos saudáveis e manejar melhor o estresse. Apesar disso, frequentemente permanecem presos aos mesmos padrões de comportamento.

Essa distância entre saber e fazer tem sido observada repetidamente na prática clínica e constitui um dos principais desafios da promoção da saúde e da mudança de comportamento.

Ao longo de sua trajetória como médica psiquiatra, psicoterapeuta corporal e professora universitária, a Dra. Renata Fáro Guerra passou a questionar se a transformação humana poderia depender de algo além da compreensão cognitiva dos problemas. A observação clínica sugeria que muitos pacientes não precisavam necessariamente de mais informação. Precisavam, antes, de uma forma diferente de acessar a própria experiência.

Essa inquietação, vivida no encontro entre a psiquiatria e a psicoterapia corporal, tornou-se uma das bases da criação da Psiquiatria Somatopsíquica.

As Influências Formadoras

A Psiquiatria Somatopsíquica não surgiu de uma única teoria ou escola de pensamento. Ela emergiu da convergência de diferentes campos do conhecimento que, embora tradicionalmente estudados de forma separada, compartilham um interesse comum pela relação entre corpo, mente e comportamento. Entre suas principais influências encontram-se:

- Psiquiatria clínica contemporânea
- Psicoterapia corporal
- Medicina do Estilo de Vida

- Neurociência afetiva
- Teoria do Marcador Somático
- Estudos sobre interocepção
- Mindfulness e práticas contemplativas
- Teoria Polivagal
- Psicologia positiva
- Abordagens experienciais corpo-mente

Ao longo dos anos, tornou-se cada vez mais evidente que emoções, pensamentos e comportamentos não poderiam ser plenamente compreendidos sem considerar a participação ativa do corpo na experiência humana.

A IPS® Antes do PROMEV

A Intervenção Psiquiátrica Somatopsíquica foi criada pela Dra. Renata Fáro Guerra antes do surgimento do PROMEV. Sua origem está no percurso da autora como médica psiquiatra e psicoterapeuta corporal e na necessidade clínica de integrar esses campos de maneira coesa, aplicável e compatível com a prática psiquiátrica.

Essa construção desenvolveu-se na prática clínica da autora, incluindo seu trabalho no Lótus Terapias e Meditação, onde a integração entre corpo, experiência subjetiva e cuidado em saúde já fazia parte de sua atuação. A IPS® não nasceu como protocolo grupal: inicialmente, constituía uma forma autoral de compreender e conduzir o cuidado clínico, articulando conhecimentos da psiquiatria e da psicoterapia corporal.

Quando o Programa Ambulatorial de Mudança de Hábito e Estilo de Vida (PROMEV) foi criado, em 2019, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-HCFMUSP), a IPS® já existia. O novo contexto ofereceu a oportunidade de adaptar e organizar essa experiência prévia para uma intervenção em grupo voltada à mudança de hábitos e ao estilo de vida.

No PROMEV, a pergunta sobre o que falta entre compreender uma mudança e efetivamente realizá-la ganhou um campo específico de aplicação, observação e sistematização.

Foi nesse contexto — e não como origem da IPS® — que foi desenvolvido o formato grupal e organizado o protocolo de oito semanas da Intervenção Psiquiátrica Somatopsíquica.

Da Experiência Clínica ao Protocolo Grupal de Oito Semanas

A passagem da IPS® já utilizada na clínica individual para um formato grupal exigiu uma nova etapa de elaboração. No PROMEV, a experiência clínica anterior foi organizada em uma sequência compartilhável e progressiva, destinada a ampliar a consciência corporal, favorecer a autorregulação emocional e apoiar mudanças de hábitos. A aplicação do protocolo de oito semanas permitiu observar de maneira sistemática alguns fenômenos recorrentes:

- Pacientes frequentemente identificavam emoções através de sensações corporais
- A percepção do corpo facilitava a compreensão de padrões emocionais
- Movimentos corporais intuitivos pareciam favorecer transformações subjetivas
- Estados de presença ampliavam a capacidade de escolha
- Experiências de gratidão e celebração fortaleciam a manutenção das mudanças

Essas observações contribuíram para o refinamento e a sistematização do método, atualmente organizado em quatro pilares — consciência corporal, presença-agência, conexão-transcendência e gratidão-celebração — e nos sete passos da IPS®. O PROMEV foi, portanto, um contexto importante para a estruturação do protocolo grupal de oito semanas, mas não o lugar de origem da IPS®.

Da Consciência Corporal à Agência

As primeiras formulações teóricas da IPS enfatizavam especialmente a relação entre consciência corporal, presença e agência. A hipótese central era que o aumento da percepção corporal favoreceria uma presença mais consistente no momento presente, criando condições para escolhas mais conscientes e alinhadas aos valores individuais. Essa formulação foi posteriormente apresentada no primeiro artigo teórico da abordagem.

A Publicação do Modelo Somatopsíquico

Em 2025, foi publicado o artigo “Theory and conception of Somatopsyche Psychiatric Intervention: a transdiagnostic body-mind intervention for psychiatric practice”. O artigo apresentou formalmente a

Intervenção Psiquiátrica Somatopsíquica como uma abordagem transdiagnóstica corpo-mente para a prática psiquiátrica. Foram descritos:

- Os fundamentos teóricos
- Os quatro pilares
- Os sete passos do protocolo
- As bases neurocientíficas relacionadas à interocepção, mindfulness, teoria polivagal e marcador somático
- O conceito de níveis de corporificação utilizado na prática clínica

Esse trabalho representou o marco inaugural da publicação científica da Psiquiatria Somatopsíquica como modelo teórico estruturado. Não corresponde, contudo, ao início de sua criação ou de sua utilização clínica, que o antecederam.

Presença, Agência e Mudança de Comportamento

A evolução da experiência clínica e da pesquisa levou posteriormente à ampliação do modelo. Em 2026, um segundo trabalho aprofundou a relação entre presença, agência e mudança sustentável de hábitos em saúde. Nesse momento, a IPS passou a dialogar de forma ainda mais próxima com a Medicina do Estilo de Vida e com os desafios da transformação comportamental.

| A questão central tornou-se: como transformar percepção em ação sustentável?

O Surgimento do Conceito de Corporificação

Ao longo dos anos de aplicação clínica da IPS, observou-se que alguns pacientes desenvolviam não apenas maior consciência corporal, mas uma nova forma de compreender a si mesmos através do corpo. Eles não apenas percebiam sensações — passavam a reconhecer relações entre sensações corporais, emoções, pensamentos, significados pessoais e comportamentos.

Essa observação levou ao desenvolvimento do conceito de corporificação.

| Na Psiquiatria Somatopsíquica, corporificação refere-se ao processo pelo qual a pessoa reconhece conscientemente as relações entre corpo, emoção, pensamento, significado e ação, utilizando essa percepção integrada para orientar escolhas mais conscientes e alinhadas aos seus valores.

A corporificação passou então a ser compreendida como um possível mecanismo intermediário entre consciência corporal e mudança comportamental sustentável.

Uma Psiquiatria Voltada para a Transformação

A Psiquiatria Somatopsíquica não pretende substituir modelos tradicionais de diagnóstico ou tratamento psiquiátrico. Seu objetivo é complementar a prática clínica por meio de uma abordagem que reconhece o corpo como participante ativo da experiência humana. Mais do que reduzir sintomas, a IPS busca ampliar a capacidade das pessoas de perceber, compreender e transformar suas próprias experiências.

Nessa perspectiva, o corpo deixa de ser apenas o local onde os sintomas se manifestam. Ele passa a ser reconhecido como uma fonte de informação, significado e transformação.

Considerações Finais

A história da Psiquiatria Somatopsíquica é a história de uma pergunta clínica simples, porém profunda: por que tantas pessoas sabem o que precisam fazer, mas encontram dificuldade para mudar?

A busca por responder essa questão levou ao desenvolvimento de um modelo que integra consciência corporal, atenção plena, corporificação, agência e mudança sustentável. Mais do que uma técnica ou protocolo, a IPS representa uma proposta de cuidado que procura aproximar conhecimento e experiência, compreensão e ação, corpo e mente.

E essa história continua sendo escrita a cada paciente, profissional e pesquisador que participa da construção dessa abordagem.

CAPÍTULO 2

A Crise da Mudança Comportamental em Saúde

Por que saber não é suficiente?

Uma das maiores contradições da medicina contemporânea é que nunca tivemos tanto conhecimento sobre saúde e, ao mesmo tempo, tantas dificuldades para transformar esse conhecimento em comportamento.

Atualmente, sabemos com razoável segurança que hábitos relacionados à alimentação, atividade física, sono, manejo do estresse, relacionamentos e uso de substâncias influenciam profundamente a saúde física e mental. A literatura científica demonstra de forma consistente que esses fatores estão associados ao risco, à evolução e ao prognóstico de diversas doenças crônicas e transtornos psiquiátricos.

Entretanto, na prática clínica cotidiana, uma realidade permanece evidente:

Informação não garante transformação.

Pacientes frequentemente saem da consulta compreendendo perfeitamente as orientações recebidas e, ainda assim, retornam semanas ou meses depois relatando que não conseguiram implementá-las ou mantê-las. Esse fenômeno não representa falta de inteligência, interesse ou motivação. Ele revela a complexidade do comportamento humano.

O Modelo Tradicional da Mudança

Historicamente, grande parte das intervenções em saúde foi construída sobre uma premissa implícita:

Conhecimento → Mudança

Segundo essa lógica, quanto mais a pessoa compreendesse seu problema e suas possíveis soluções, maior seria a probabilidade de mudança. Embora o conhecimento seja essencial, a experiência clínica demonstra que essa relação é frequentemente insuficiente. Muitos pacientes sabem exatamente:

- O que deveriam comer
- Quanto deveriam dormir
- Que precisam se exercitar
- Que precisam estabelecer limites
- Que precisam reduzir o consumo de álcool
- Que precisam cuidar da saúde mental

Ainda assim, continuam repetindo comportamentos que reconhecem como prejudiciais. Essa observação sugere que existe um espaço entre compreender e agir que não pode ser explicado apenas pela cognição.

A Lacuna Entre Intenção e Ação

Diversos modelos da psicologia e das ciências do comportamento descrevem um fenômeno conhecido como “intention-behavior gap” — a lacuna entre intenção e comportamento. Em outras palavras: as pessoas frequentemente desejam mudar antes de conseguirem mudar. Ter intenção não significa possuir recursos suficientes para sustentar a transformação.

A mudança comportamental depende de múltiplos fatores:

- Percepção
- Regulação emocional
- Crenças
- Autoeficácia
- Ambiente
- Suporte social
- Experiências corporais
- Significado pessoal

A IPS propõe que o corpo participa ativamente dessa equação.

O Corpo Como Participante da Mudança

Durante muito tempo, o corpo foi compreendido principalmente como o local onde os sintomas aparecem. Ansiedade produz taquicardia. Medo produz tensão. Tristeza produz lentificação. Raiva produz ativação fisiológica.

Entretanto, pesquisas contemporâneas em neurociência, interocepção e cognição incorporada sugerem uma perspectiva diferente. O corpo não apenas expressa estados mentais — ele participa da construção desses estados. Sensações corporais influenciam emoções, pensamentos, tomada de decisão e comportamento.

Nessa perspectiva, a mudança comportamental não ocorre exclusivamente no plano cognitivo. Ela também envolve processos corporais.

A Aplicação do Problema Clínico no PROMEV

A lacuna entre conhecimento e ação já fazia parte das questões clínicas que contribuíram para a criação da IPS®. Posteriormente, no Programa Ambulatorial de Mudança de Hábito e Estilo de Vida (PROMEVI), essa questão ganhou um campo específico de aplicação: muitos pacientes possuíam conhecimento suficiente sobre as mudanças desejadas, mas encontravam dificuldade para implementá-las e sustentá-las.

| O problema não era saber. O problema era sustentar.

Muitos relatavam: “Eu começo, mas não consigo continuar.” Outros afirmavam: “Na teoria parece fácil, mas na hora eu faço tudo diferente.” Ou ainda: “Quando percebo, já voltei ao mesmo padrão.”

Esses relatos sugeriam que a dificuldade não estava apenas no planejamento racional. Existiam processos mais profundos influenciando as escolhas cotidianas.

Quando o Corpo Fala Antes da Consciência

Frequentemente, antes que uma emoção seja reconhecida conscientemente, o corpo já apresenta sinais. Por exemplo, uma pessoa pode perceber aperto no peito, tensão na mandíbula, desconforto abdominal ou alteração respiratória — somente depois reconhecer ansiedade, medo, tristeza ou raiva.

Em muitos casos, o comportamento surge como resposta automática a esses estados corporais antes mesmo que a pessoa compreenda o que está acontecendo. É nesse ponto que a consciência corporal se torna relevante.

Da Consciência Corporal à Transformação

A IPS propõe que a transformação sustentável depende de uma sequência progressiva de processos:

Perceber → Permanecer → Compreender → Escolher → Incorporar

Ou, em sua formulação teórica:

Consciência Corporal → Atenção Plena → Corporificação → Agência → Mudança Sustentável

O indivíduo inicialmente percebe sinais corporais. Posteriormente aprende a permanecer presente diante deles. Em seguida compreende seus significados. Essa compreensão favorece escolhas mais conscientes. Com o tempo, essas escolhas tornam-se parte da própria identidade e do modo de viver.

O Papel da Agência

Mesmo quando uma pessoa percebe claramente suas emoções e compreende suas necessidades, a mudança ainda não está garantida. É necessário acreditar que se é capaz de agir. A esse processo a IPS denomina agência.

Agência refere-se à capacidade percebida de influenciar a própria experiência por meio de escolhas e ações.

Sem agência, a consciência pode gerar frustração. Com agência, a consciência pode gerar transformação.

Além da Redução de Sintomas

Tradicionalmente, muitos modelos terapêuticos concentram-se na redução de sintomas. Embora esse objetivo seja importante, a IPS propõe uma ampliação dessa perspectiva. O foco não está apenas em reduzir sofrimento — está também em desenvolver capacidades. Entre elas:

- Consciência corporal
- Atenção plena
- Corporificação
- Agência
- Conexão
- Propósito
- Gratidão

Essas capacidades podem funcionar como recursos internos para sustentar a saúde ao longo da vida.

Uma Nova Pergunta Clínica

A partir dessa perspectiva, a consulta clínica passa a incluir uma nova pergunta. Em vez de perguntar apenas “O que o paciente sabe?” ou “O que o paciente sente?”, a IPS convida o profissional a perguntar:

O que impede que aquilo que ele sabe e sente se transforme em ação?

Essa mudança de foco desloca a atenção do conteúdo para o processo. E é nesse processo que a Psiquiatria Somatopsíquica encontra seu campo de atuação.

Considerações Finais

A crise da mudança comportamental em saúde não decorre da falta de informação. Ela reflete a complexidade dos processos que conectam conhecimento, emoção, corpo e ação.

A IPS propõe que a transformação sustentável emerge quando o indivíduo desenvolve a capacidade de perceber sua experiência corporal, permanecer presente diante dela, compreender seus significados e utilizá-la para orientar escolhas alinhadas aos seus valores.

Nesse contexto, a mudança deixa de ser apenas um ato de força de vontade. Ela passa a ser um processo de integração. E é justamente essa integração que constitui o núcleo da Psiquiatria Somatopsíquica.

CAPÍTULO 3

Corpo, Mente e Comportamento

Fundamentos Neuropsicobiológicos da Psiquiatria Somatopsíquica

Os capítulos anteriores apresentaram a questão clínica que deu origem à Psiquiatria Somatopsíquica: por que tantas pessoas compreendem o que precisam fazer, mas não conseguem transformar esse conhecimento em comportamento? Para avançar nessa pergunta, é necessário examinar como corpo, mente e ação se influenciam continuamente.

A IPS parte de uma premissa central: estados corporais não são apenas consequências passivas de pensamentos e emoções. Eles participam da experiência subjetiva, da regulação emocional, da tomada de decisão e dos padrões de comportamento. Este capítulo reúne os fundamentos neuropsicobiológicos utilizados pela mentoria para sustentar essa perspectiva.

A Psiquiatria Somatopsíquica compreende corpo e mente como dimensões inseparáveis da experiência humana. Essa integração constitui a base teórica do método IPS®.

3.1 O Fim da Separação entre Corpo e Mente

Durante séculos, o pensamento ocidental foi fortemente influenciado pelo dualismo cartesiano, que descrevia mente e corpo como entidades distintas. Essa separação contribuiu para avanços importantes ao permitir o estudo sistemático do organismo, mas também favoreceu modelos clínicos nos quais processos mentais e corporais passaram a ser examinados de forma isolada.

Na psiquiatria contemporânea, essa divisão mostra limites. Emoções envolvem alterações autonômicas, endócrinas, musculares e viscerais; pensamentos modificam estados corporais; e sinais provenientes do organismo influenciam percepção, memória, decisão e ação. A relação é bidirecional: a mente afeta o corpo e o corpo participa da construção da mente.

A IPS insere-se nessa visão integrada. Ela não se propõe a substituir os modelos diagnósticos, psicoterápicos ou farmacológicos estabelecidos. Seu objetivo é acrescentar uma via estruturada de acesso à experiência corporal, ampliando as possibilidades de compreensão e autorregulação na prática psiquiátrica.

3.2 O Corpo Como Fonte de Informação

Para que uma pessoa reconheça o próprio estado, o sistema nervoso integra informações provenientes de diferentes vias sensoriais. Três conceitos são especialmente relevantes para a IPS:

- Interocepção — percepção de sinais relacionados à condição interna do organismo, como batimentos cardíacos, respiração, temperatura, fome, saciedade, desconforto visceral e tensão.
- Propriocepção — percepção da posição, do movimento e da relação entre as partes do corpo, mesmo sem o auxílio da visão.
- Exterocepção — percepção das informações provenientes do ambiente, como sons, luz, temperatura externa, contato e distância.

Essas informações são continuamente integradas. O cérebro não espera uma descrição verbal para organizar o estado do organismo: ele recebe sinais, compara-os com experiências anteriores e contribui para construir a percepção do que está acontecendo.

Pergunta clínica central: como o paciente reconhece que está ansioso, triste, irritado, seguro ou em risco? Muitas vezes, a primeira resposta disponível está no corpo.

Na IPS, ampliar a consciência corporal significa aprender a direcionar atenção a esses sinais com curiosidade, aceitação e menor julgamento. O objetivo não é vigiar o organismo nem interpretar automaticamente cada sensação, mas aumentar a qualidade da informação disponível para a consciência.

3.3 Emoções Começam no Corpo?

A relação entre emoção e corpo acompanha a história da psicologia e da neurociência. William James destacou a participação das alterações corporais na experiência emocional. Mais tarde, Antonio Damasio formulou a hipótese dos marcadores somáticos, segundo a qual sinais corporais associados a experiências anteriores contribuem para orientar decisões, sobretudo em situações complexas ou incertas.

Nessa perspectiva, uma emoção não é apenas uma ideia sobre o que aconteceu. Ela envolve mudanças no organismo e a percepção — consciente ou não — dessas mudanças. Taquicardia, alteração respiratória, contração abdominal, calor, tremor ou redução da vitalidade podem integrar a experiência de medo, ansiedade, raiva ou tristeza.

Isso não significa que toda sensação possua um significado único. Um aperto no peito pode ocorrer em diferentes condições clínicas e emocionais. A tarefa do aplicador não é impor uma interpretação, mas ajudar o paciente a observar contexto, sequência e relações possíveis entre sensação, emoção, pensamento e comportamento.

Exemplo clínico: aperto no peito → reconhecimento de ansiedade → percepção do impulso de evitar. Ao tornar a sequência consciente, abre-se espaço para investigação e escolha.

3.4 O Cérebro Prediz Antes de Perceber

Modelos contemporâneos de processamento preditivo propõem que o cérebro interpreta sinais corporais e ambientais à luz de experiências anteriores. A percepção não seria uma leitura puramente passiva do mundo, mas o resultado da interação entre sinais recebidos e previsões sobre o que eles significam.

Aplicada ao corpo, essa perspectiva ajuda a compreender por que determinadas sensações podem ser rapidamente associadas a perigo, rejeição, ameaça ou fracasso. Em algumas situações, respostas autonômicas e comportamentais são mobilizadas antes que a pessoa consiga formular conscientemente o que aconteceu.

A Teoria Polivagal, incorporada ao referencial teórico da IPS, enfatiza a relação entre estados autonômicos, percepção de segurança e disponibilidade para conexão social. O conceito de neurocepção descreve a avaliação de sinais de segurança, perigo ou ameaça à vida sem depender necessariamente de análise consciente.

Na aplicação clínica, esses modelos funcionam como referências para compreender reações rápidas e corporificadas. Eles não autorizam interpretações automáticas do estado do paciente. A observação

clínica deve considerar história, contexto, diagnóstico diferencial, estabilidade e a experiência relatada pela própria pessoa.

Por que às vezes reagimos antes de pensar? Porque processos corporais, autonômicos e preditivos podem organizar uma resposta antes que ela se torne uma narrativa consciente.

3.5 Interocepção e Saúde Mental

A literatura utilizada na construção da IPS relaciona alterações interoceptivas a diferentes formas de sofrimento psíquico. Ansiedade e depressão, dificuldades de regulação emocional, trauma, dissociação, alexitimia, dependência química e alterações do comportamento alimentar podem envolver padrões distintos de percepção, interpretação ou utilização dos sinais corporais.

A interocepção, porém, não deve ser tratada como uma capacidade única que é simplesmente “boa” quando aumenta. Uma pessoa pode perceber intensamente os sinais internos e interpretá-los como ameaçadores; outra pode ter dificuldade para identificá-los; outra pode alternar entre hipervigilância e desconexão. Por isso, o trabalho clínico envolve qualidade de atenção, contexto, tolerância e capacidade de regulação.

O manuscrito teórico da IPS propõe a interocepção como um mecanismo transdiagnóstico relevante, ao lado da consciência corporal, da regulação emocional e da agência. Ao mesmo tempo, reconhece que a intervenção ainda se encontra em processo de validação empírica e não deve ter sua efetividade presumida antes de estudos clínicos adequados.

3.6 O Corpo Como Regulador

O corpo não é apenas fonte de sinais; ele também oferece possibilidades de intervenção. No protocolo IPS®, práticas corporais são utilizadas para favorecer presença, percepção, transformação da experiência e reconhecimento de autoeficácia.

- Respiração — permite observar o estado atual e pode apoiar a estabilização, sem impor um padrão único ao paciente.
- Movimento — amplia alternativas diante da imobilidade e participa do passo de Agência Somatopsíquica.
- Grounding — direciona atenção aos apoios corporais, ao contato com o solo e ao momento presente.

- Vibração — é apresentada no protocolo como recurso corporal para relaxamento e redução de tensão muscular.
- Consciência corporal — permite mapear sensações antes e depois da prática, apoiando a comparação da experiência.

No protocolo detalhado da mentoria, o grounding inaugura a prática, o mapeamento aprofunda interocepção e propriocepção, a agência utiliza movimento, postura ou som, e o remapeamento permite observar o que se modificou. Essa sequência transforma o paciente de observador passivo em participante ativo da própria experiência.

A escolha do recurso deve respeitar segurança, estabilidade clínica, consentimento e tolerância. Em pacientes com sintomas dissociativos, história de trauma, desregulação emocional intensa ou instabilidade psiquiátrica, a aproximação do corpo pode exigir adaptação gradual e acompanhamento mais intensivo. A IPS não é recomendada durante estados psicóticos ou maníacos agudos, conforme o manuscrito da intervenção.

3.7 Da Sensação ao Comportamento

A partir dos fundamentos apresentados, a IPS organiza uma sequência clínica que conecta experiência corporal e ação:

| Sensação → Percepção → Emoção → Significado → Escolha → Comportamento

A sensação é o dado corporal inicial. A percepção torna esse dado disponível à consciência. A emoção organiza a experiência afetiva. O significado relaciona a experiência ao contexto e à história da pessoa. A escolha introduz agência. O comportamento expressa a ação realizada e, quando repetido, pode contribuir para a consolidação de novos padrões.

Essa sequência não deve ser entendida como uma cadeia rígida ou invariável. Na experiência humana, essas dimensões se influenciam reciprocamente e podem ocorrer de maneira muito rápida. Seu valor clínico está em oferecer um mapa para desacelerar o processo e investigar pontos que normalmente permanecem automáticos.

3.8 Implicações Clínicas

A incorporação do corpo à escuta clínica não exige abandonar perguntas sobre pensamentos, emoções, sintomas ou contexto. Ela acrescenta perguntas que aproximam o paciente da experiência:

- O que acontece no seu corpo quando isso ocorre?
- Onde você percebe essa experiência?
- O que apareceu primeiro: a sensação, o pensamento ou o impulso de agir?
- Essa sensação muda quando você a observa?
- O que você percebe antes de repetir esse comportamento?

Essas perguntas devem ser formuladas como convites, não como exigências. O aplicador evita sugerir respostas, atribuir significados universais ou transformar metáforas corporais em diagnósticos. A experiência pertence ao paciente; o profissional oferece condições para que ela seja percebida, descrita e integrada.

A mudança clínica mais importante é a passagem de uma escuta centrada apenas no conteúdo para uma escuta que também acompanha o processo: o que surge, em que sequência, como se manifesta no corpo e como se relaciona às escolhas realizadas.

Considerações Finais

Corpo, mente e comportamento formam um sistema integrado. Sinais interoceptivos, proprioceptivos e exteroceptivos participam da experiência emocional; estados corporais influenciam decisões; previsões e respostas autonômicas podem organizar reações antes da elaboração consciente; e práticas corporais podem ampliar percepção e possibilidades de regulação.

A Psiquiatria Somatopsíquica utiliza esses fundamentos para construir uma intervenção estruturada. Sua proposta é ajudar o paciente a perceber sinais corporais, permanecer presente, investigar significados e desenvolver agência. Como modelo em validação, a IPS deve ser aplicada com rigor clínico, prudência e compromisso com a produção progressiva de evidências.

A transformação comportamental não ocorre apenas porque uma pessoa compreende racionalmente uma situação. Ela se torna possível quando a experiência é percebida, sentida, integrada e utilizada para orientar escolhas.

Esse percurso prepara o conceito central do próximo capítulo: corporificação, o processo pelo qual a experiência corporal deixa de ser apenas sensação e passa a participar da compreensão, da escolha e da transformação.

Este capítulo foi desenvolvido exclusivamente a partir do manuscrito teórico da IPS, do protocolo detalhado das oito sessões e do capítulo de Psiquiatria Somatopsíquica para Medicina do Estilo de Vida. Entre as referências científicas já reunidas nesses materiais estão:

- Farb et al. — Interoception, contemplative practice, and health (2015).
- Craig — How do you feel? Interoception: the sense of the physiological condition of the body (2002).
- Seth e Critchley — Extending predictive processing to the body: emotion as interoceptive inference (2013).
- Damasio — hipótese dos marcadores somáticos e estudos sobre experiência emocional corporificada.
- Porges — The polyvagal perspective (2007).
- Price e Hooven — Interoceptive Awareness Skills for Emotion Regulation (2018).
- Payne, Levine e Crane-Godreau — interocepção e propriocepção em terapia orientada ao corpo (2015).

CAPÍTULO 4

Corporificação: Da Percepção à Transformação

O Mecanismo Central da Psiquiatria Somatopsíquica

Introdução

Ao longo dos capítulos anteriores, discutimos dois fenômenos amplamente observados na prática clínica. Primeiro, que muitas pessoas sabem o que precisam fazer para melhorar sua saúde, mas encontram dificuldades para transformar esse conhecimento em comportamento. Segundo, que o corpo participa ativamente da construção da experiência humana, influenciando emoções, pensamentos, decisões e ações.

Entretanto, uma questão permanece: como a percepção corporal se transforma em mudança sustentável?

A Psiquiatria Somatopsíquica propõe que essa transformação ocorre por meio de um processo denominado corporificação. A corporificação representa o elo entre perceber e agir, entre compreender e transformar, entre experiência e comportamento.

O Que é Corporificação?

Na IPS, corporificação é definida como o processo pelo qual a pessoa reconhece conscientemente as relações entre sensações corporais, emoções, pensamentos, significados pessoais e padrões de ação, utilizando essa percepção integrada para orientar escolhas mais conscientes e alinhadas aos seus valores.

Essa definição contém três elementos fundamentais:

- 1. Percepção — a pessoa percebe o que acontece no corpo.
- 2. Integração — a pessoa compreende o significado da experiência corporal.
- 3. Utilização — a pessoa utiliza essa compreensão para orientar suas escolhas.

A corporificação, portanto, não se limita à percepção corporal. Ela envolve transformação da percepção em significado e do significado em ação.

O Que a Corporificação Não É

Para compreender melhor o conceito, é importante diferenciá-lo de outros construtos relacionados.

Corporificação não é apenas Interocepção. A interocepção responde à pergunta “O que estou sentindo em meu corpo?” (tensão muscular, taquicardia, calor, aperto no peito, desconforto abdominal). A corporificação vai além: ela pergunta “O que essa sensação me revela sobre minha experiência?”

Corporificação não é apenas Atenção Plena. A atenção plena permite observar a experiência presente com abertura e aceitação — “Consigo permanecer consciente do que está acontecendo?”. A corporificação acrescenta: “Consigo compreender o significado do que está acontecendo?”

Corporificação não é apenas Insight. O insight produz compreensão; a corporificação produz integração. O insight pode ocorrer cognitivamente; a corporificação envolve simultaneamente corpo, emoção, cognição, significado e ação.

O Corpo Como Fonte de Significado

Tradicionalmente, o corpo foi compreendido como um local de manifestação de sintomas. Na IPS, o corpo é compreendido como uma fonte de informação — mas também como uma fonte de significado.

Por exemplo: um paciente relata ansiedade. Durante o mapeamento somatopsíquico identifica: “Existe uma pressão forte no meu peito.” A intervenção não termina aí. O próximo passo é investigar: quando essa sensação aparece? O que ela tenta comunicar? Com quais situações ela se relaciona?

Gradualmente, o paciente pode perceber: “Essa sensação surge quando tento corresponder às expectativas dos outros.” Nesse momento, o corpo deixa de ser apenas sensação. Torna-se informação significativa.

O Processo de Corporificação

A IPS propõe que a corporificação ocorre em cinco movimentos progressivos:

Sentir → Reconhecer → Compreender → Escolher → Incorporar

Sentir — o indivíduo percebe uma sensação corporal. Exemplo: “Meu estômago está contraído.”

Reconhecer — ele identifica a experiência. Exemplo: “Estou ansioso.”

Compreender — ele atribui significado. Exemplo: “Tenho medo de decepcionar as pessoas.”

Escolher — ele identifica uma possibilidade de ação. Exemplo: “Posso estabelecer um limite.”

Incorporar — a nova escolha torna-se um padrão de vida. Exemplo: “Passei a respeitar meus limites com mais frequência.”

Os Cinco Níveis de Corporificação

A IPS descreve a corporificação como um continuum de desenvolvimento.

Corporificação e Agência

A IPS propõe que a corporificação prepara o terreno para a agência.

Sem corporificação:

Sensação → Reação Automática

Com corporificação:

Sensação → Compreensão → Escolha → Ação

A diferença entre os dois caminhos pode determinar a manutenção ou a transformação de um comportamento.

Corporificação e Mudança Sustentável

Muitas mudanças fracassam porque permanecem apenas no plano da intenção. A pessoa tenta agir contra seus padrões sem compreendê-los profundamente. A IPS propõe que mudanças mais sustentáveis ocorrem quando a experiência corporal é percebida, seu significado é compreendido, novas escolhas são realizadas e essas escolhas são repetidas até se tornarem parte da identidade.

Nesse sentido, a corporificação atua como uma ponte entre consciência e transformação.

O Modelo IPS de Mudança Sustentável

A partir dessa perspectiva, a Psiquiatria Somatopsíquica propõe o seguinte modelo:

Consciência Corporal → Atenção Plena → Corporificação → Agência → Mudança Sustentável

A consciência corporal permite perceber. A atenção plena permite permanecer presente. A corporificação permite compreender. A agência permite agir. A mudança sustentável representa a consolidação dessas transformações na vida cotidiana.

Implicações Clínicas

Quando o médico aprende a trabalhar com corporificação, sua escuta se transforma. Além de perguntar “O que você pensa?” ou “O que você sente?”, ele passa a perguntar “O que acontece no seu corpo quando isso acontece?” e depois “O que essa sensação pode estar tentando lhe mostrar?”

Essa mudança aparentemente simples desloca a atenção do conteúdo para a experiência. E é justamente nesse espaço que a IPS busca promover transformação.

Considerações Finais

A corporificação representa um dos conceitos centrais da Psiquiatria Somatopsíquica. Ela descreve o processo pelo qual experiências corporais deixam de ser apenas sensações e passam a tornar-se fontes de compreensão, escolha e transformação.

Mais do que perceber o corpo, corporificar significa aprender a escutá-lo, compreendê-lo e utilizá-lo como aliado na construção de uma vida mais consciente, coerente e alinhada aos próprios valores.

A partir desse entendimento, torna-se possível compreender os quatro pilares da IPS, tema do Capítulo 5.

Os Quatro Pilares da Psiquiatria Somatopsíquica

A Arquitetura Conceitual da IPS®

Introdução

Os capítulos anteriores apresentaram a crise da mudança comportamental, os fundamentos da relação corpo-mente e o conceito de corporificação. Este capítulo organiza esses elementos na arquitetura conceitual que sustenta a Intervenção Psiquiátrica Somatopsíquica: seus quatro pilares.

Na formulação atualizada da IPS®, os pilares são:

- 1º pilar — Consciência Corporal
- 2º pilar — Presença-Agência
- 3º pilar — Conexão-Transcendência
- 4º pilar — Gratidão-Celebração

Os quatro pilares não representam etapas isoladas. Eles descrevem capacidades que se articulam ao longo da experiência somatopsíquica: perceber, estar presente e agir, conectar-se e ampliar significado, reconhecer e consolidar recursos.

A atualização da nomenclatura torna explícitas duas relações que já estavam presentes nos materiais da mentoria. A agência depende de acesso à experiência presente; por isso, presença e agência formam um mesmo eixo. A transcendência envolve uma forma de conexão que ultrapassa os limites habituais do eu; por isso, conexão e transcendência constituem outro eixo integrado.

5.1 Primeiro Pilar — Consciência Corporal

A consciência corporal é a porta de entrada da IPS®. Ela corresponde à capacidade de perceber o corpo e reconhecer relações entre sensações, emoções, pensamentos e contexto. Nos materiais teóricos da intervenção, essa capacidade inclui especialmente propriocepção, interocepção e atenção plena.

A propriocepção informa posição e movimento corporal. A interocepção permite perceber sinais relacionados ao estado interno do organismo. A atenção plena oferece uma qualidade de observação

marcada por presença, aceitação, curiosidade e menor julgamento. Juntas, essas dimensões ajudam o paciente a transformar sinais difusos em experiência percebida.

Pergunta central do primeiro pilar: o que está acontecendo em meu corpo neste momento?

Na prática da IPS®, a consciência corporal é desenvolvida principalmente pelo grounding e pelo mapeamento somatopsíquico. O paciente é convidado a reconhecer apoios, respiração, tensão, temperatura, movimento, vitalidade e outras qualidades da experiência corporal.

O aplicador não atribui significados universais às sensações. Sua função é favorecer uma observação segura e suficientemente precisa para que o próprio paciente reconheça relações possíveis entre o que acontece no corpo e o que vive emocionalmente.

Função Clínica da Consciência Corporal

- Tornar perceptíveis sinais que antes passavam despercebidos.
- Aproximar sensação corporal e experiência emocional.
- Reconhecer gatilhos, impulsos e respostas automáticas.
- Criar uma base experiencial para regulação, decisão e mudança.

Consciência corporal, isoladamente, não garante transformação. Perceber sem conseguir permanecer diante da experiência ou atuar sobre ela pode inclusive aumentar frustração e desamparo. Por essa razão, o primeiro pilar conduz necessariamente ao segundo.

5.2 Segundo Pilar — Presença-Agência

Presença e agência formam o eixo que conecta percepção e ação. A presença permite permanecer em contato com a experiência atual. A agência permite responder a essa experiência de forma intencional, utilizando escolhas, movimentos e recursos que favoreçam transformação e bem-estar.

Presença: Habitar a Experiência

Na mentoria, presença é compreendida como a capacidade de se conectar plenamente com o momento presente, consigo e com o contexto. Ela envolve contato com sensações, emoções, pensamentos e ambiente sem que a pessoa seja imediatamente capturada por respostas automáticas.

O grounding participa desse processo ao orientar atenção aos pés, às pernas, aos apoios e ao aqui e agora. A segurança relacional também é central: atitude empática, voz acolhedora, contato respeitoso e um ambiente cooperativo contribuem para que o paciente consiga permanecer em contato com a própria experiência.

| Pergunta da presença: consigo permanecer em contato com o que está acontecendo agora?

Agência: Participar da Própria Transformação

Agência refere-se à capacidade de agir intencionalmente sobre a própria experiência, promovendo mudanças em direção ao bem-estar. Nos materiais da IPS®, ela se relaciona à autorresponsabilidade, à autoeficácia e à possibilidade de reconhecer que uma ação própria pode modificar a experiência.

Na Agência Somatopsíquica, o paciente é convidado a explorar movimentos, posturas ou sons de forma intuitiva e criativa. Em seguida, o remapeamento permite comparar a experiência antes e depois da ação. Essa comparação não busca provar controle absoluto sobre o corpo, mas tornar perceptível a participação ativa do paciente no processo.

| Pergunta da agência: o que posso fazer, neste momento, para participar de forma consciente da minha experiência?

Por Que Presença e Agência Formam um Único Pilar?

Sem presença, a ação tende a repetir padrões automáticos porque a pessoa não reconhece com clareza o que está acontecendo. Sem agência, a presença pode permanecer apenas contemplativa, sem se traduzir em possibilidade de escolha. Na formulação atualizada da IPS®, as duas capacidades são trabalhadas como um ciclo:

| Presença → percepção do estado atual → possibilidade de escolha → agência → nova percepção

O aplicador não pressiona o paciente a produzir mudança. Ele ajuda a construir condições para que a ação seja possível, proporcional e segura. Em alguns momentos, a escolha mais adequada pode ser movimentar-se; em outros, pausar, pedir ajuda, estabelecer um limite, descansar ou não agir imediatamente.

5.3 Terceiro Pilar — Conexão-Transcendência

Conexão-transcendência é o eixo que amplia a experiência para além da percepção isolada do corpo. Ele inclui conexão consigo, com o outro, com o contexto e, conforme a compreensão pessoal do paciente, com algo maior do que si mesmo.

Conexão: Relação Consigo, com o Outro e com o Mundo

A conexão começa internamente quando a pessoa reconhece sua experiência sem rejeitá-la ou se afastar imediatamente dela. Também possui uma dimensão relacional: segurança, vínculo e engajamento social podem favorecer estados de calma, abertura e regulação.

Os materiais da mentoria relacionam essa dimensão à percepção de segurança descrita pela Teoria Polivagal. Na prática clínica, essa referência não deve ser utilizada para classificar rigidamente estados autonômicos, mas para lembrar que a disponibilidade para exploração corporal depende do contexto relacional e da estabilidade do paciente.

Pergunta da conexão: com quem, com o quê e de que maneira estou me relacionando nesta experiência?

Transcendência: Ampliar Significado e Perspectiva

A transcendência é apresentada nos materiais da IPS® como uma forma de conhecimento que ultrapassa os limites físicos e habituais do eu. Pode envolver espiritualidade, natureza, humanidade, universo, conhecimento, valores ou sabedoria interior, de acordo com a visão e a linguagem de cada paciente.

No Insight Somatopsíquico, o paciente é convidado a abrir-se para uma palavra, frase ou imagem que possa oferecer nova perspectiva ao desafio trabalhado. Essa prática integra o mundo interno — incluindo a experiência interoceptiva — e referências que transcendem o indivíduo.

Pergunta da transcendência: que perspectiva mais ampla pode ajudar a compreender ou orientar esta experiência?

Cuidados Éticos no Pilar Conexão-Transcendência

A espiritualidade nunca deve ser presumida, prescrita ou conduzida segundo as crenças do aplicador. A IPS® acolhe interpretações religiosas, espirituais, filosóficas, humanistas, agnósticas e ateias. O profissional utiliza a linguagem do paciente, respeita seus limites e evita apresentar conteúdos intuitivos como verdades objetivas.

Insight não substitui avaliação clínica, diagnóstico diferencial, planejamento terapêutico nem tomada de decisão compartilhada. Ele é uma experiência a ser integrada criticamente à biografia, ao contexto e aos valores da pessoa.

5.4 Quarto Pilar — Gratidão–Celebração

Gratidão–celebração é o eixo de reconhecimento e consolidação. Ele desloca temporariamente a atenção do que falta para aquilo que foi vivido, aprendido, alcançado ou recebido, sem negar sofrimento, perdas ou objetivos ainda não realizados.

Gratidão: Reconhecer Recursos e Percurso

Nos materiais da mentoria, a gratidão é apresentada como recurso associado ao bem-estar e ao cultivo de emoções positivas. No protocolo de oito sessões, ela ajuda o paciente a revisar a própria trajetória e perceber transformações, aprendizados e recursos que poderiam permanecer invisíveis.

A metáfora do “GPS mental” descreve essa função: ao reconhecer de onde partiu, o que atravessou e onde se encontra, a pessoa localiza sua posição atual com maior precisão. Gratidão, nesse contexto, não significa conformismo nem obrigação de sentir-se bem.

Pergunta da gratidão: o que consigo reconhecer, hoje, em meu percurso, em meus recursos ou em minhas relações?

Celebração: Corporificar o Reconhecimento

A celebração transforma o reconhecimento em experiência vivida. No protocolo IPS®, ela pode envolver movimento e dança, permitindo que gratidão, conquista e autovalorização sejam percebidas corporalmente, e não apenas afirmadas de maneira cognitiva.

Celebrar não exige grandiosidade nem um resultado perfeito. O foco pode estar no esforço, em uma pequena mudança, na capacidade de permanecer no processo ou em um aprendizado relevante. A forma de celebração deve respeitar cultura, preferência, condição física e grau de exposição tolerado pelo paciente.

Pergunta da celebração: como posso permitir que esse reconhecimento seja sentido e marcado no corpo?

Por Que Gratidão e Celebração Formam um Único Pilar?

A gratidão identifica aquilo que merece reconhecimento; a celebração dá expressão corporal e simbólica a esse reconhecimento. Na formulação atualizada da IPS®, o par evita que a gratidão permaneça apenas como pensamento abstrato e ajuda a integrar conquistas à experiência presente.

Esse pilar amplia o foco para além da redução de sintomas e se alinha ao objetivo da IPS® de favorecer bem-estar, resiliência e florescimento humano. Entretanto, não deve ser usado para minimizar sofrimento, apressar encerramentos ou produzir positividade compulsória.

5.5 Como os Quatro Pilares se Articulam

Os pilares descrevem capacidades distintas, mas interdependentes:

- Consciência Corporal permite perceber a experiência.
- Presença-Agência permite permanecer, escolher e participar da transformação.
- Conexão-Transcendência permite relacionar-se e ampliar significado e perspectiva.
- Gratidão-Celebração permite reconhecer, expressar e consolidar recursos e mudanças.

| Perceber → permanecer e agir → conectar e ampliar → reconhecer e celebrar

Essa sequência é didática, não rígida. Em uma mesma sessão, o paciente pode transitar várias vezes entre os pilares. A gratidão pode aumentar presença; a conexão pode favorecer segurança; a agência pode ampliar consciência corporal; e uma nova percepção pode modificar o significado atribuído à experiência.

5.6 Relação entre os Pilares e os Sete Passos

Os quatro pilares constituem a arquitetura conceitual; os sete passos constituem a organização prática do método. Não existe correspondência exclusiva entre um pilar e um único passo, mas algumas relações são especialmente visíveis:

- Consciência Corporal — grounding, mapeamento e remapeamento somatopsíquico.
- Presença-Agência — grounding, Agência Somatopsíquica, remapeamento e atenção plena.
- Conexão-Transcendência — segurança relacional, Insight Somatopsíquico, atenção plena e fechamento.
- Gratidão-Celebração — aplicação integrada dos sete passos no modo gratidão-celebração.

O capítulo seguinte apresentará os sete passos em profundidade, mostrando como essa arquitetura se transforma em uma sequência clínica estruturada.

5.7 Implicações para o Aplicador

Os pilares ajudam o profissional a compreender qual capacidade precisa ser apoiada em determinado momento. Diante de um paciente desconectado do corpo, pode ser necessário priorizar consciência corporal e presença. Quando há percepção sem possibilidade de ação, o trabalho pode se concentrar em agência. Quando a experiência perde sentido ou vínculo, conexão-transcendência pode oferecer uma nova direção. Ao integrar mudanças, gratidão-celebração pode ajudar a reconhecê-las e consolidá-las.

Essa leitura não deve ser usada como classificação fixa do paciente. O aplicador formula hipóteses, observa respostas e ajusta a condução. Segurança, consentimento, estabilidade clínica e respeito à singularidade permanecem critérios transversais aos quatro pilares.

Considerações Finais

Os quatro pilares da formulação atualizada da Psiquiatria Somatopsíquica organizam uma trajetória que começa na percepção corporal, passa pela presença e pela capacidade de agir, amplia conexão e significado e culmina no reconhecimento corporificado de recursos e transformações.

| *Consciência Corporal • Presença-Agência • Conexão-Transcendência • Gratidão-Celebração*

Mais do que temas teóricos, os pilares funcionam como referências para a escuta e para a condução clínica. Eles permitem ao aplicador observar não apenas o conteúdo trazido pelo paciente, mas as capacidades que sustentam a integração entre corpo, emoção, pensamento, significado e comportamento.

Como toda a IPS®, essa arquitetura deve ser utilizada com prudência e compreendida como parte de um modelo ainda em validação empírica. Sua função, neste manual, é oferecer coerência conceitual ao método e preparar o estudo dos sete passos.

Este capítulo foi desenvolvido a partir da atualização conceitual informada pela autora e das seguintes fontes internas da mentoria:

- Manuscrito teórico da Intervenção Psiquiátrica Somatopsíquica.
- Protocolo detalhado das oito sessões da IPS®.

- Capítulo “Psiquiatria Somatopsíquica: uma proposta para integrar a teoria mente-corpo na clínica psiquiátrica”, publicado em Medicina do Estilo de Vida.

As principais referências científicas já reunidas nesses materiais incluem estudos sobre consciência corporal e interocepção, Teoria Polivagal, agência, transcendência, atenção plena, gratidão e bem-estar. A atualização dos pares Presença-Agência e Conexão-Transcendência foi incorporada conforme orientação expressa da autora do método.

CAPÍTULO 6

Os Sete Passos e os Dois Modos de Experiência

A Organização Prática do Método IPS®

Introdução

Os quatro pilares apresentados no capítulo anterior constituem a arquitetura conceitual da Psiquiatria Somatopsíquica. Os sete passos constituem sua organização prática: uma sequência estruturada para ajudar a pessoa a retornar ao corpo, mapear a experiência, participar ativamente de sua transformação, integrar significado e relacionar o que viveu à própria história e às escolhas cotidianas.

Os sete passos podem ser utilizados por duas vias de transformação somatopsíquica:

- Modo Transformação — via direta, utilizada para trabalhar uma emoção, pensamento, crença, comportamento ou padrão corporal que a pessoa deseja transformar.
- Modo Gratidão–Celebração — via mediada por recursos, utilizada para entrar em contato corporal com a gratidão, expressá-la por meio da celebração e integrá-la como recurso capaz de ampliar a experiência e transformar a maneira de relacionar-se com uma situação.

Na IPS®, ambos os modos podem estar a serviço da transformação. O que os diferencia não é a possibilidade de mudança, mas o ponto de entrada da experiência: no Modo Transformação, parte-se diretamente daquilo que pede mudança; no Modo Gratidão–Celebração, parte-se de um recurso de gratidão. Os dois modos seguem a mesma arquitetura dos sete passos, com intenções e instruções específicas. O aplicador deve definir claramente o modo antes de iniciar a experiência.

6.1 A Estrutura Geral dos Sete Passos

A prática é organizada na seguinte sequência:

- Passo 1 — Presença e enraizamento–grounding
- Passo 2 — Mapeamento somatopsíquico
- Passo 3 — Agência somatopsíquica
- Passo 4 — Remapeamento somatopsíquico
- Passo 5 — Insight

- Passo 6 — Atenção plena
- Passo 7 — Fechamento

Presença → Mapeamento → Agência → Remapeamento → Insight → Atenção Plena → Fechamento

Antes do primeiro passo, existe uma escolha orientadora. No Modo Transformação, a pessoa escolhe o que deseja transformar. No Modo Gratidão-Celebração, escolhe pelo que deseja sentir gratidão e qual das três formas de gratidão utilizará.

A sequência oferece direção, mas não deve ser conduzida mecanicamente. O aplicador observa segurança, tolerância, estabilidade e resposta clínica durante todo o processo. A pessoa pode pausar, reduzir intensidade ou encerrar a prática a qualquer momento.

6.2 A Escolha Inicial

No Modo Transformação

A pessoa escolhe uma questão de intensidade tolerável. Pode ser uma emoção, um pensamento, uma crença, um comportamento ou um padrão corporal. A escolha precisa ser suficientemente específica para permitir o mapeamento, mas não tão intensa que ultrapasse a capacidade atual de presença e regulação.

Pergunta orientadora: o que desejo compreender ou transformar nesta prática?

No Modo Gratidão-Celebração

A pessoa escolhe algo pelo qual deseja sentir gratidão. A experiência pode partir de algo real e presente, de um aprendizado encontrado em uma dificuldade ou da visualização de algo desejado como se já tivesse acontecido. Essas possibilidades correspondem aos três tipos descritos adiante: puro, pescaria e “como se”.

Pergunta orientadora: com qual experiência de gratidão desejo entrar em contato hoje?

6.3 Passo 1 — Presença e Enraizamento-Grounding

O primeiro passo tem a função de favorecer presença e segurança. A pessoa volta a atenção aos pés, ao contato com o chão, aos apoios do corpo e ao momento atual. O grounding ajuda a deslocar a atenção da narrativa mental para a experiência corporal situada.

O ambiente e a relação também participam do enraizamento. Voz acolhedora, explicações claras, consentimento, possibilidade de escolha e ausência de pressão ajudam a construir condições para a prática.

| Para lembrar: voltar ao corpo, aos pés, ao chão e ao momento presente.

Nos Dois Modos

O Passo 1 preserva a mesma finalidade no Modo Transformação e no Modo Gratidão–Celebração. Antes de explorar uma dificuldade ou cultivar gratidão, a pessoa precisa encontrar uma base suficientemente segura de presença.

6.4 Passo 2 — Mapeamento Somatopsíquico

O mapeamento é a observação das sensações corporais associadas ao tema escolhido. Pode começar superficialmente, percorrendo o corpo de cima para baixo e de baixo para cima, e aprofundar-se em uma sensação específica.

No mapeamento profundo, a pessoa pode reconhecer localização, intensidade, temperatura, textura, forma, cor, direção, movimento e som. Esses elementos não possuem significado universal; são recursos descritivos para aumentar precisão e contato com a experiência.

No Modo Transformação

A pessoa reconhece como a emoção, pensamento, crença, comportamento ou padrão escolhido aparece no corpo. O objetivo inicial não é modificar a sensação, mas percebê-la com clareza e tolerância.

| Pergunta: onde e como essa questão aparece em meu corpo?

No Modo Gratidão–Celebração

A pessoa conecta-se com a gratidão no tipo escolhido e observa onde e como ela aparece no corpo. Pode perceber calor, expansão, suavidade, vitalidade, movimento, respiração, postura ou qualquer outra qualidade presente, sem exigir uma sensação específica.

Pergunta: onde e como a gratidão aparece em meu corpo?

6.5 Passo 3 — Agência Somatopsíquica

Agência somatopsíquica é a participação ativa do corpo no processo. A pessoa é convidada a permitir movimentos, posições, gestos, sons, respiração, dança, vibração ou mudanças sutis de postura, conforme a experiência e os limites atuais.

No Modo Transformação

Os movimentos e recursos são explorados com a intenção de apoiar transformação da sensação-emoção mapeada. A ação nasce do contato corporal: primeiro perceber, depois experimentar uma resposta possível.

Para lembrar: permitir movimentos, posições, sons ou gestos que apoiem transformação.

No Modo Gratidão-Celebração

O terceiro passo assume a forma de dança celebrativa. A celebração pode ser pequena, ampla, silenciosa ou expressiva. Não exige euforia nem desempenho. Sua função é permitir que o reconhecimento seja vivido corporalmente.

Para lembrar: permitir movimento e expressão em uma dança celebrativa.

6.6 Passo 4 — Remapeamento Somatopsíquico

No remapeamento, a pessoa interrompe o movimento e observa novamente o corpo. O objetivo é comparar a experiência atual com o mapeamento inicial, reconhecendo o que mudou e o que permaneceu.

No Modo Transformação

A pessoa observa possíveis mudanças no corpo, na emoção e na percepção depois da agência somatopsíquica. O resultado não precisa ser desaparecimento do desconforto. Pode haver alteração de intensidade, forma, localização, movimento, relação com a sensação ou capacidade de permanecer presente.

Pergunta: o que mudou depois da agência?

No Modo Gratidão–Celebração

A pessoa observa como o corpo se encontra depois da celebração. O remapeamento permite reconhecer como a experiência celebrativa repercutiu no corpo, acrescentando uma nova camada à gratidão inicialmente mapeada.

Pergunta: o que mudou em meu corpo depois da vivência da celebração?

6.7 Passo 5 — Insight

Depois do contato corporal, da agência e do remapeamento, a pessoa leva atenção ao centro cardíaco e adota uma postura interna de receptividade. Conforme sua compreensão pessoal, pode conectar-se com Deus, Vida, Universo, Natureza, Consciência, valores ou sabedoria interna.

O convite é aguardar uma palavra, frase ou imagem, sem esforço. O insight não precisa aparecer e não deve ser fabricado. Quando surge, é acolhido como material de compreensão e integração, não como ordem ou verdade absoluta.

No Modo Transformação

O insight pode oferecer uma nova compreensão da questão escolhida, de sua relação com a história pessoal ou de uma possibilidade de cuidado e ação.

No Modo Gratidão–Celebração

O insight pode oferecer uma palavra, frase ou imagem que fortaleça o caminho da gratidão–celebração e ajude a reconhecer o que essa experiência ensina.

Cuidado: o insight não deve ser usado para justificar decisões impulsivas. Deve ser integrado com discernimento, realidade concreta e, quando necessário, orientação profissional.

6.8 Passo 6 — Atenção Plena

A pessoa senta-se em silêncio e observa respiração, corpo, emoções, pensamentos e estímulos externos com curiosidade, abertura, aceitação e não julgamento. O objetivo não é eliminar pensamentos, mas permitir que a experiência reverbere e se organize sem intervenção imediata.

Na IPS®, a etapa de atenção plena é orientada por três chaves:

- Relaxamento.
- Observação ou testemunho.
- Não julgamento.

| Para lembrar: sentar em silêncio, observar e deixar reverberar, sem julgamento.

6.9 Passo 7 — Fechamento

O fechamento relaciona a experiência vivida à história, ao momento atual e às escolhas da pessoa. Ele evita que a prática permaneça como acontecimento isolado e favorece a passagem de experiência para discernimento e vida cotidiana.

No Modo Transformação

A pessoa investiga o que a experiência tem a ver com sua história e seu momento atual e identifica um pequeno passo de integração ou cuidado.

| Pergunta: o que isso tem relação com minha história, meu momento e meu próximo passo?

No Modo Gratidão–Celebração

A pessoa reconhece o que aquela gratidão ensina para sua vida e como pode sustentar esse reconhecimento depois da prática.

| Pergunta: o que essa gratidão ensina para minha vida?

6.10 Modo Transformação — Roteiro Integrado

No Modo Transformação, a prática completa segue esta organização:

- Escolha — selecionar uma emoção, pensamento, crença, comportamento ou padrão corporal que deseja transformar.
- Passo 1 — voltar aos pés, ao chão e ao corpo.
- Passo 2 — reconhecer como a questão aparece no corpo.
- Passo 3 — permitir movimentos, sons, posições ou gestos que ajudem a transformar.
- Passo 4 — observar o que mudou.

- Passo 5 — receber uma palavra, frase ou imagem.
- Passo 6 — sentar em silêncio e deixar reverberar.
- Passo 7 — integrar com a história e escolher um pequeno passo.

A transformação não é medida apenas pela redução imediata de desconforto. Também pode aparecer como maior clareza, flexibilidade, tolerância, percepção de escolha, reconhecimento de limites ou disposição para buscar apoio.

6.11 Modo Gratidão-Celebração — Roteiro Integrado

No Modo Gratidão-Celebração, a mesma arquitetura é direcionada ao cultivo e à corporificação da gratidão:

- Escolha — selecionar pelo que se sente gratidão e definir um dos três tipos: puro, pescaria ou “como se”.
- Passo 1 — voltar ao corpo com segurança e realizar o grounding.
- Passo 2 — conectar-se com a gratidão escolhida e perceber onde e como ela aparece no corpo.
- Passo 3 — permitir movimento e expressão em uma dança celebrativa.
- Passo 4 — observar como o corpo mudou depois da celebração.
- Passo 5 — receber palavra, frase ou imagem que possa fortalecer o caminho da gratidão-celebração.
- Passo 6 — sentar em silêncio e permitir que a experiência se integre.
- Passo 7 — reconhecer o que essa gratidão ensina para a vida.

| Celebrar não exige euforia. Pode ser um gesto discreto de reconhecimento verdadeiro.

6.12 Os Três Tipos de Gratidão

O Modo Gratidão-Celebração pode ser iniciado por três formas de contato com a gratidão. Cada uma modifica a escolha inicial, mas todas seguem posteriormente os sete passos.

1. Gratidão no Modo “Como Se”

Consiste em entrar em contato com a gratidão como se aquilo que a pessoa deseja já tivesse sido concretizado. A pessoa visualiza a experiência desejada e observa corporalmente como seria sentir gratidão por essa realização.

Neste modo, a gratidão é experimentada por algo visualizado como se já tivesse acontecido.

O “como se” é uma experiência imaginativa de contato com a gratidão. Não representa afirmação de que o resultado ocorrerá, promessa terapêutica nem substituição de planejamento, ação concreta ou avaliação da realidade.

2. Gratidão no Modo “Pescaria”

Diante de um conflito ou dificuldade, a pessoa “pesca” algo pelo qual pode sentir gratidão, como crescimento, aprendizagem, ampliação do olhar, fortalecimento ou humanidade.

Neste modo, a pessoa pensa na questão, reconhece dentro dela algo verdadeiro pelo qual pode sentir gratidão e realiza os sete passos a partir desse elemento. Após a experiência, a situação pode permanecer a mesma, mas a pessoa pode conseguir lidar com ela de maneira diferente, ampliar seus recursos e construir um novo olhar sobre o que viveu.

A pescaria não transforma sofrimento em obrigação de agradecer. O aplicador não força uma aprendizagem positiva, não minimiza injustiça ou perda e não apressa ressignificação. A gratidão só é utilizada quando existe um elemento verdadeiro que a própria pessoa consegue reconhecer.

3. Gratidão no Modo Puro

Consiste em olhar para o percurso e permitir gratidão por tudo que fez parte do processo: presença, entrega, coragem, passos dados e processo vivido. No modo puro, a gratidão dirige-se ao que efetivamente foi vivido e reconhecido.

Neste modo, a gratidão dirige-se ao percurso, à presença, à entrega, à coragem, aos passos dados e ao processo vivido.

Esse tipo é especialmente coerente com momentos de integração e encerramento, mas pode ser utilizado sempre que a pessoa desejar reconhecer recursos e experiências reais já presentes em sua trajetória.

6.13 Como Escolher entre os Dois Modos

A escolha depende da porta de entrada mais adequada para a experiência. Quando a pessoa deseja partir diretamente de uma questão, utiliza-se o Modo Transformação. Quando deseja partir de um recurso de

gratidão — inclusive para ampliar a maneira de lidar com uma questão — utiliza-se o Modo Gratidão-Celebração. Ambos podem estar a serviço da transformação.

O aplicador evita alternar de modo sem explicação no meio da experiência. Se um tema diferente surgir, ele pode ser reconhecido e registrado para outro momento. A clareza do enquadre ajuda o paciente a compreender o sentido de cada instrução.

Modo Transformação: via direta, partindo da questão que pede mudança. Modo Gratidão-Celebração: via mediada por um recurso de gratidão que pode ampliar e reorganizar a relação com a experiência.

6.14 Segurança e Limites da Prática

A IPS® estabelece uma regra de ouro: a pessoa não precisa ir mais fundo do que consegue sustentar. Profundidade sem segurança não é integração. Antes de iniciar, o aplicador ajuda a escolher uma questão de intensidade tolerável, preparar o ambiente e reforçar que a prática pode ser pausada.

A prática deve ser interrompida diante de desconforto intenso, perda de controle, tontura, falta de ar, dor, mal-estar físico, dissociação, sensação de estar fora do corpo, memórias traumáticas invasivas, impulso de autoagressão ou heteroagressão ou piora importante dos sintomas.

Questões traumáticas, intensas ou repetitivas exigem avaliação e acompanhamento profissional apropriado. O protocolo não substitui tratamento médico ou psicoterápico e não deve ser aplicado em estados psicóticos ou maníacos agudos, conforme o manuscrito teórico da IPS®.

Eu posso ir devagar. Eu posso pausar. Eu posso pedir ajuda. Meu processo não precisa ser perfeito para ser verdadeiro.

6.15 Implicações para o Aplicador

Conhecer os sete passos não significa apenas memorizar a sequência. O aplicador precisa compreender a função clínica de cada passo, diferenciar os dois modos, observar segurança e utilizar linguagem que preserve autonomia e singularidade.

- Explicar o modo e a intenção antes de iniciar.
- Oferecer instruções claras sem sugerir quais sensações ou insights devem aparecer.
- Acompanhar sinais de ativação, desconexão, fadiga ou perda de presença.

- Respeitar silêncio, ausência de movimento, ausência de insight e necessidade de pausa.
- Não interpretar sensações, imagens ou movimentos como significados universais.
- Concluir com integração clínica e um próximo passo proporcional.

A fidelidade ao método não está na rigidez. Está em preservar a função dos passos, a diferença entre os modos e os princípios de segurança, presença, autorresponsabilidade e não julgamento.

Considerações Finais

Os sete passos transformam os pilares da Psiquiatria Somatopsíquica em uma experiência clínica organizada. O Modo Transformação utiliza a sequência como via direta para trabalhar uma questão escolhida. O Modo Gratidão–Celebração utiliza a mesma arquitetura como via mediada por recursos para mapear, expressar e integrar gratidão nos tipos “como se”, pescaria ou puro. Ambos os modos podem produzir transformação.

Uma arquitetura, duas vias de transformação somatopsíquica: partir diretamente do que pede mudança ou partir de um recurso de gratidão capaz de ampliar a experiência e favorecer um novo olhar.

Nos dois casos, o método começa pela presença, passa pelo corpo e pela agência, abre espaço para insight e atenção plena e termina relacionando a experiência à história e à vida prática. Essa organização prepara o estudo do C.O.R.A.G.E.M.[®], tema do próximo capítulo.

CAPÍTULO 7

C.O.R.A.G.E.M.®

Um Guia Interno para Agir Diante de Situações Desafiadoras

Introdução

C.O.R.A.G.E.M.® é um guia interno para momentos em que a pessoa se encontra diante de algo desafiador para realizar, como uma decisão, uma conversa importante ou um passo que provoca medo. Cada letra indica um movimento de reflexão que pode ajudá-la a avançar com mais consciência.

O percurso reúne sete referências: Coração, Oração, Resistência, Ação, Gentileza, Emergir e Momento a Momento.

| Coração → Oração → Resistência → Ação → Gentileza → Emergir → Momento a Momento

7.1 A Estrutura do C.O.R.A.G.E.M.®

O guia é organizado pelas letras da palavra CORAGEM:

- C — Coração
- O — Oração: conexão com algo maior
- R — Resistência
- A — Ação
- G — Gentileza
- E — Emergir
- M — Momento a Momento

Cada referência convida a pessoa a formular uma pergunta e observar sua própria resposta. O objetivo não é oferecer uma resposta pronta, mas apoiar uma reflexão pessoal diante do desafio escolhido.

7.2 C — Coração

O Coração recorda aquilo que torna a ação importante. A pessoa é convidada a reconhecer a paixão, o valor ou o propósito que está por trás do que deseja realizar. Quando se lembra do coração daquilo que quer, sua motivação pode tornar-se mais clara e profunda.

Perguntas: *por que isso é importante para mim? Qual é a paixão, o valor ou o propósito que está por trás dessa ação?*

7.3 O — Oração: Conexão com Algo Maior

No C.O.R.A.G.E.M.[®], oração não precisa ter sentido religioso. Trata-se de um momento de conexão com o transcendente, com algo maior do que a própria pessoa.

O material apresenta como possibilidades de conexão:

- Espiritualidade.
- Valores.
- Natureza.
- Silêncio.
- Consciência.

Pergunta: *como essa conexão pode me sustentar neste passo?*

7.4 R — Resistência

Toda mudança encontra resistência. Neste movimento, a pessoa observa com curiosidade como a resistência se manifesta em sua vida, reconhecendo possíveis formas pelas quais ela adia, evita ou se afasta da ação.

Perguntas propostas no guia:

- Eu estou procrastinando?
- Estou sentindo medo?
- Estou buscando distrações?
- Estou dizendo “depois eu faço”?

Reconhecer a resistência tira o poder dela.

7.5 A — Ação

Depois de reconhecer o que importa, conectar-se com algo maior e observar a resistência, a pessoa escolhe um pequeno passo concreto. A ação não precisa ser perfeita; precisa apenas existir.

| Pergunta: qual é a primeira ação possível agora?

7.6 G — Gentileza

Mudanças exigem energia e vulnerabilidade. Gentileza significa tratar-se de maneira cuidadosa durante o processo.

O guia propõe:

- Não se cobrar de forma excessiva.
- Falar consigo como falaria com alguém querido.
- Reconhecer o esforço.

| Pergunta: como posso ser gentil comigo neste processo?

7.7 E — Emergir

Emergir é permitir que a própria verdade apareça. O convite é não agir apenas para corresponder a expectativas externas e não tentar ser outra pessoa.

| Pergunta: o que é autêntico para mim aqui?

A pessoa é orientada a deixar emergir aquilo que realmente é seu e a anotar aspectos autênticos que passou a observar melhor depois de iniciar a ação. O material propõe realizar esse registro por pelo menos sete dias.

7.8 M — Momento a Momento

A mudança não acontece de uma vez. Momento a Momento recorda que ela é um processo, e não um evento. O percurso acontece passo a passo.

| Pergunta: eu estou presente comigo, com o outro e com o contexto?

7.9 Roteiro Integrado

Diante de uma decisão, uma conversa importante ou um passo que provoca medo, o percurso pode ser lembrado nesta sequência:

- Coração — reconhecer por que a ação é importante e qual valor, paixão ou propósito a sustenta.
- Oração — conectar-se com algo maior e perceber como essa conexão pode oferecer sustentação.
- Resistência — observar com curiosidade a procrastinação, o medo, as distrações ou o adiamento.
- Ação — escolher a primeira ação pequena e possível.
- Gentileza — reduzir a cobrança excessiva, falar consigo com cuidado e reconhecer o esforço.
- Emergir — perceber o que é autêntico e registrar o que aparece ao longo de pelo menos sete dias.
- Momento a Momento — lembrar que a mudança é um processo e retornar à presença consigo, com o outro e com o contexto.

7.10 Orientações para o Aplicador

Ao utilizar o C.O.R.A.G.E.M.[®], o aplicador apresenta o guia e conduz as perguntas na ordem proposta. As respostas pertencem à pessoa: cabe a ela reconhecer o que é importante, o que a sustenta, como a resistência aparece, qual ação é possível, como exercer gentileza, o que é autêntico e como permanecer presente ao longo do processo.

- Escolher com a pessoa uma situação desafiadora concreta: uma decisão, uma conversa importante ou um passo que provoca medo.
- Apresentar uma letra e sua pergunta de cada vez.
- Dar espaço para que a resposta seja formulada pela própria pessoa.
- Ao chegar à Ação, favorecer a escolha de um pequeno passo concreto e possível.
- No Emergir, orientar o registro dos aspectos autênticos observados por pelo menos sete dias.
- Retomar Momento a Momento como lembrança de que mudança é processo, não evento.

Síntese

CORAGEM não é ausência de medo. É caminhar mesmo quando ele está presente.

O C.O.R.A.G.E.M.® organiza uma travessia consciente diante do desafio: recordar o que importa, conectar-se com algo maior, reconhecer a resistência, escolher uma ação possível, tratar-se com gentileza, permitir que o autêntico emergja e sustentar o percurso momento a momento.

Fonte da Mentoria Utilizada Neste Capítulo

Este capítulo foi desenvolvido exclusivamente a partir do documento “CORAGEM”, de autoria da Dra. Renata Fáro Guerra. A sequência, os significados de cada letra, as perguntas, as possibilidades de conexão e a proposta de registro por pelo menos sete dias foram preservados conforme o material fornecido.

MAIA-2

Avaliação Multidimensional da Consciência Interoceptiva

Introdução

A Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness — Version 2 (MAIA-2) é um instrumento de autorrelato composto por 37 itens e oito dimensões. Foi desenvolvido para avaliar diferentes maneiras pelas quais uma pessoa percebe, interpreta e se relaciona conscientemente com suas sensações corporais.

A MAIA-2 não mede a precisão objetiva com que alguém detecta sinais fisiológicos. Ela investiga a experiência interoceptiva relatada pela própria pessoa: o que percebe no corpo, como direciona a atenção, como reage ao desconforto e em que medida utiliza o corpo para regulação, compreensão e orientação.

A MAIA-2 não produz uma única medida de “quanto” a pessoa sente o corpo. Ela descreve um perfil de como a pessoa se relaciona com a experiência corporal.

8.1 Origem e Atualização da Escala

A primeira MAIA foi publicada em 2012 com 32 itens distribuídos em oito dimensões. Estudos posteriores identificaram menor consistência interna especialmente nas dimensões Não se Distrair e Não se Preocupar. A MAIA-2, publicada por Mehling e colaboradores em 2018, acrescentou cinco itens à versão anterior e manteve a estrutura de oito dimensões, totalizando 37 itens.

No estudo original da MAIA-2, 1.090 participantes responderam ao conjunto de itens. A análise confirmou o modelo de oito fatores e mostrou melhora da consistência interna das dimensões que haviam motivado a revisão. Ainda assim, os autores recomendam interpretar cada dimensão separadamente e considerar que o desempenho psicométrico pode variar entre populações e contextos culturais.

8.2 A Tradução Brasileira

O site oficial da MAIA, mantido pelo Osher Center for Integrative Health da University of California, San Francisco, disponibiliza uma tradução para o português brasileiro realizada por Ricardo Carvalho, do

Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. O material é classificado pelo próprio site como tradução adaptada com painel de especialistas.

Até as fontes consultadas para este capítulo, o site oficial não apresenta um estudo publicado de validação psicométrica dessa tradução em amostra brasileira. Por isso, este manual utiliza a expressão tradução brasileira adaptada, e não versão brasileira validada.

Precisão terminológica: tradução brasileira adaptada da MAIA-2. Não afirmar validação psicométrica brasileira sem a publicação de um estudo específico.

8.3 As Oito Dimensões

1. Notar — Itens 1 a 4

Avalia a percepção de sensações corporais desconfortáveis, confortáveis e neutras, como tensão, conforto, desconforto e mudanças na respiração.

2. Não se Distrair — Itens 5 a 10

Avalia a tendência a não ignorar nem se distrair de sensações de dor ou desconforto. Todos os seis itens desta dimensão possuem pontuação invertida.

3. Não se Preocupar — Itens 11 a 15

Avalia a tendência a não reagir com preocupação ou sofrimento emocional diante de dor ou desconforto corporal. Os itens 11, 12 e 15 possuem pontuação invertida; os itens 13 e 14 são pontuados diretamente.

4. Regulação da Atenção — Itens 16 a 22

Avalia a capacidade de sustentar, controlar e redirecionar a atenção para as sensações corporais, inclusive na presença de distrações.

5. Consciência Emocional — Itens 23 a 27

Avalia a percepção da relação entre sensações corporais e estados emocionais. Esta dimensão é denominada Emotional Awareness no instrumento original; portanto, não deve ser substituída por Consciência Corporal.

6. Autorregulação — Itens 28 a 31

Avalia a capacidade relatada de regular sofrimento, estresse ou agitação por meio da atenção dirigida ao corpo e à respiração.

7. Escuta Corporal — Itens 32 a 34

Avalia a escuta ativa das sensações e necessidades corporais como fonte de compreensão do estado emocional e de orientação para escolhas.

8. Confiança — Itens 35 a 37

Avalia a experiência do corpo como lugar seguro e confiável e a confiança nas próprias sensações corporais.

8.4 Aplicação

A tradução brasileira apresenta 37 afirmações e solicita que a pessoa indique a frequência com que cada situação se aplica à sua vida cotidiana. Cada item é respondido em uma escala de seis pontos:

- 0 — Nunca.
- 1 — Frequência muito baixa.
- 2 — Frequência baixa.
- 3 — Frequência moderada.
- 4 — Frequência alta.
- 5 — Sempre.

Os extremos 0 — Nunca e 5 — Sempre constam no formulário oficial. Os valores intermediários representam gradações de frequência e devem ser apresentados de maneira uniforme durante a aplicação, sem modificar o sentido dos itens.

O respondente deve considerar como cada afirmação se aplica a ele de modo geral no dia a dia. O aplicador evita explicar o item de forma que sugira uma resposta considerada desejável.

8.5 Pontuação Invertida

Antes do cálculo das médias, alguns itens precisam ser invertidos porque foram redigidos no sentido oposto ao nome da dimensão.

- Não se Distrair — inverter os itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
- Não se Preocupar — inverter os itens 11, 12 e 15.

A fórmula oficial de inversão é:

$$\text{Pontuação invertida} = 5 - \text{resposta original}$$

Assim, 0 torna-se 5; 1 torna-se 4; 2 torna-se 3; 3 torna-se 2; 4 torna-se 1; e 5 torna-se 0. Os itens 13 e 14 não são invertidos.

8.6 Cálculo das Subescalas

A pontuação de cada dimensão corresponde à média aritmética de seus itens, depois das inversões necessárias:

- Notar — soma dos itens 1 a 4, dividida por 4.
- Não se Distrair — soma das pontuações invertidas dos itens 5 a 10, dividida por 6.
- Não se Preocupar — soma dos itens 11 a 15, com inversão de 11, 12 e 15, dividida por 5.
- Regulação da Atenção — soma dos itens 16 a 22, dividida por 7.
- Consciência Emocional — soma dos itens 23 a 27, dividida por 5.
- Autorregulação — soma dos itens 28 a 31, dividida por 4.
- Escuta Corporal — soma dos itens 32 a 34, dividida por 3.
- Confiança — soma dos itens 35 a 37, dividida por 3.

Cada dimensão apresenta resultado entre 0 e 5. As instruções oficiais estabelecem o cálculo das oito médias separadamente. Não estabelecem uma soma global obrigatória, um escore total oficial ou pontos de corte clínicos.

8.7 Interpretação do Perfil

A interpretação deve ser dimensional. Depois das inversões, uma média mais alta indica maior presença da capacidade descrita pela subescala. Isso não significa que toda pontuação alta, considerada isoladamente, represente necessariamente melhor funcionamento clínico.

Uma pessoa pode, por exemplo, apresentar pontuação elevada em Notar e perceber intensamente suas sensações, mas obter pontuações mais baixas em Não se Preocupar, Autorregulação ou Confiança. Nesse caso, existe percepção corporal, porém acompanhada de preocupação, dificuldade de regulação ou pouca segurança na relação com o corpo.

A pergunta clínica não é apenas “quanto a pessoa percebe?”, mas “como ela se relaciona com aquilo que percebe?”.

O aplicador observa o desenho formado pelas oito dimensões, suas relações com a narrativa clínica e sua evolução ao longo do tempo. Resultados não devem ser transformados automaticamente em rótulos como baixo, médio ou alto sem normas e pontos de corte apropriados para a população avaliada.

8.8 Uso da MAIA-2 no Contexto da IPS®

Na IPS®, a MAIA-2 pode auxiliar a descrição e o acompanhamento das capacidades relacionadas à consciência interoceptiva. Sua estrutura dialoga especialmente com o primeiro pilar, Consciência Corporal, e com processos de presença, regulação, escuta do corpo e confiança corporal.

A escala pode ser utilizada para comparar o perfil da mesma pessoa em momentos diferentes, desde que sejam mantidas condições semelhantes de aplicação. Eventuais mudanças devem ser analisadas em conjunto com entrevista, observação clínica, relatos do paciente e demais instrumentos definidos pelo programa.

A MAIA-2 avalia dimensões específicas da experiência interoceptiva. Ela não mede, por si só, toda a corporificação proposta pela IPS®, que também envolve integração entre sensação, emoção, pensamento, significado, escolha e comportamento.

8.9 Limites e Cuidados

- É um instrumento de autorrelato e depende da compreensão e da percepção subjetiva do respondente.

- Não mede acurácia interoceptiva objetiva.
- Não constitui instrumento diagnóstico isolado.
- Não possui pontos de corte clínicos oficiais para classificar indivíduos.
- As oito dimensões devem ser interpretadas separadamente e em conjunto, evitando reduzir o perfil a uma única nota.
- A tradução brasileira oficial é adaptada, mas não deve ser descrita como psicometricamente validada no Brasil sem estudo publicado específico.
- Comparações ao longo do tempo não demonstram, isoladamente, que uma intervenção causou a mudança observada.

A MAIA-2 organiza perguntas sobre a experiência corporal. A interpretação clínica continua exigindo contexto, escuta e prudência.

8.10 Implicações para o Aplicador

- Utilizar o formulário brasileiro oficial sem alterar silenciosamente seus itens.
- Explicar que não existem respostas certas ou erradas.
- Conferir o preenchimento antes de calcular as médias.
- Aplicar corretamente as nove inversões: itens 5 a 12 e item 15.
- Calcular e registrar as oito subescalas separadamente.
- Apresentar o resultado como perfil multidimensional, sem diagnóstico ou ponto de corte inventado.
- Relacionar as pontuações à história e à experiência atual da pessoa.
- Manter o mesmo método de aplicação quando a escala for repetida para acompanhamento.

Considerações Finais

A MAIA-2 oferece uma linguagem organizada para observar diferentes formas de consciência interoceptiva. Suas oito dimensões distinguem percepção, atenção, reação ao desconforto, consciência emocional, autorregulação, escuta e confiança corporal.

No contexto da Psiquiatria Somatopsíquica, sua principal contribuição não está em produzir uma nota total, mas em tornar visível o perfil de relação da pessoa com o próprio corpo e acompanhar como esse perfil se modifica ao longo do processo.

Fontes Utilizadas Neste Capítulo

Mehling, W. E., Acree, M., Stewart, A., Silas, J. e Jones, A. (2018). The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness, Version 2 (MAIA-2). PLOS ONE, 13(12), e0208034. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208034>

University of California, San Francisco — Osher Center for Integrative Health. Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness: página oficial, instrumento, instruções de pontuação e traduções. <https://osher.ucsf.edu/research/maia>

Carvalho, R. Tradução brasileira adaptada do Questionário de Avaliação Multidimensional da Consciência Interoceptiva — MAIA-2. Departamento de Psicobiologia, Universidade Federal de São Paulo. Disponibilizada pelo Osher Center/UCSF.

FFMQ-BR

Questionário das Facetas de Mindfulness

Introdução

O Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) é um instrumento de autorrelato destinado a avaliar mindfulness disposicional como um construto multidimensional. A versão completa possui 39 itens, respondidos em escala de frequência de cinco pontos.

O instrumento original foi desenvolvido por Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer e Toney em 2006. Sua estrutura conceitual reúne cinco facetas: Observar, Descrever, Agir com Consciência, Não Julgar a Experiência Interna e Não Reagir à Experiência Interna.

O FFMQ não avalia se a pessoa “medita bem”. Ele descreve diferentes maneiras de prestar atenção e relacionar-se com a experiência presente.

9.1 Origem do Instrumento

Baer e colaboradores reuniram 112 itens provenientes de cinco questionários de mindfulness existentes. Em uma amostra de 613 universitários, a análise fatorial exploratória identificou cinco fatores interpretáveis. A estrutura foi posteriormente examinada por análise confirmatória em uma amostra independente.

Para compor o questionário final, foram mantidos os sete itens de Não Reagir e selecionados os oito itens com maiores cargas fatoriais para cada uma das outras quatro facetas, resultando em 39 itens.

O estudo original também mostrou que a organização das facetas pode variar conforme a experiência com meditação. Em participantes sem experiência meditativa, a faceta Observar nem sempre se comportou como componente do mesmo fator hierárquico das demais.

9.2 Correção da Referência Brasileira

O capítulo “Questionário das Facetas de Mindfulness”, de Souza e Hutz, publicado em 2013 no livro Avaliação em Psicologia Positiva, é citado em algumas bibliotecas como referência em português. Entretanto, ele não é o estudo psicométrico brasileiro principal.

A adaptação transcultural e a investigação das propriedades psicométricas da FFMQ-BR foram publicadas por Barros, Kozasa, Souza e Ronzani em 2014. Esse é o estudo que deve fundamentar a afirmação de que o instrumento possui evidências de validade no Brasil.

Referência correta da validação brasileira: Barros, Kozasa, Souza e Ronzani (2014), e não Souza e Hutz (2013).

9.3 As Cinco Facetas Originais

1. Observar

Refere-se a perceber ou prestar atenção a experiências internas e externas, como sensações, emoções, pensamentos, sons, cheiros e elementos visuais.

2. Descrever

Refere-se à capacidade de identificar e colocar em palavras sentimentos, pensamentos, crenças e outras experiências internas.

3. Agir com Consciência

Refere-se a prestar atenção à atividade em andamento, em contraste com agir mecanicamente, no piloto automático ou com a atenção dispersa.

4. Não Julgar a Experiência Interna

Refere-se a adotar uma postura não avaliativa diante de pensamentos e emoções, reduzindo julgamentos como certo ou errado, normal ou anormal, aceitável ou inaceitável.

5. Não Reagir à Experiência Interna

Refere-se a permitir que pensamentos, imagens e sentimentos surjam e desapareçam sem reagir imediatamente, sem ser dominado por eles e sem se prender à experiência.

9.4 O Que Mudou na Validação Brasileira

A FFMQ-BR preservou os 39 itens e as cinco facetas conceituais do instrumento original. Contudo, a análise fatorial exploratória realizada no Brasil encontrou sete fatores, porque duas facetas se dividiram:

- Descrever dividiu-se em formulação positiva e formulação negativa.
- Agir com Consciência dividiu-se em piloto automático e distração.

Assim, a estrutura empírica encontrada na validação brasileira foi:

- Não Julgar a Experiência Interna — 8 itens.
- Agir com Consciência: Piloto Automático — 5 itens.
- Observar — 8 itens.
- Descrever: Formulação Positiva — 5 itens.
- Descrever: Formulação Negativa — 3 itens.
- Não Reagir à Experiência Interna — 7 itens.
- Agir com Consciência: Distração — 3 itens.

A solução de sete fatores explicou 49,56% da variância no estudo brasileiro. As duas divisões não criam novas facetas teóricas: representam subdivisões de Descrever e Agir com Consciência observadas no comportamento psicométrico dos itens em português.

Conceitualmente, o FFMQ possui cinco facetas. Na validação brasileira, os 39 itens se organizaram empiricamente em sete fatores.

9.5 Estudo Brasileiro de Validação

O estudo brasileiro avaliou 395 adultos: 97 fumantes em tratamento, 123 participantes da comunidade, 139 universitários e 36 meditadores com prática regular. Cinquenta universitários participaram também do reteste.

A consistência interna foi $\alpha = 0,81$ para o escore total. Nos sete fatores, os coeficientes variaram de 0,63 a 0,79. As correlações teste–reteste variaram de 0,67 a 0,85 nas facetas, e foram 0,90 para o escore total.

Os meditadores apresentaram resultados significativamente superiores ao grupo comparável de não meditadores no escore total e em todos os fatores. Os autores consideraram os resultados evidências iniciais satisfatórias de validade e confiabilidade, mas recomendaram novos estudos em diferentes populações e contextos brasileiros.

9.6 Aplicação

A FFMQ-BR é autoaplicável e contém 39 afirmações. A pessoa seleciona a alternativa que melhor descreve a frequência com que cada afirmação é verdadeira para ela:

- 1 — Nunca ou raramente verdadeiro.
- 2 — Às vezes verdadeiro.
- 3 — Não tenho certeza.
- 4 — Normalmente verdadeiro.
- 5 — Quase sempre ou sempre verdadeiro.

O aplicador apresenta as instruções de modo neutro, evita sugerir respostas desejáveis e verifica se todos os itens foram respondidos antes de calcular os resultados.

9.7 Itens com Pontuação Invertida

Dezenove itens possuem formulação negativa e precisam ser invertidos para que pontuações mais altas mantenham o mesmo sentido geral de maior presença da habilidade de mindfulness.

- Descrever: itens 12, 16 e 22.
- Agir com Consciência: itens 5, 8, 13, 18, 23, 28, 34 e 38.
- Não Julgar: itens 3, 10, 14, 17, 25, 30, 35 e 39.

A inversão segue esta correspondência:

1 torna-se 5 • 2 torna-se 4 • 3 permanece 3 • 4 torna-se 2 • 5 torna-se 1

Os itens de Observar e Não Reagir são pontuados diretamente. Depois da inversão, os fatores Descrever: Formulação Negativa, Agir com Consciência: Piloto Automático e Agir com Consciência: Distração passam a indicar maior habilidade, e não maior dificuldade.

9.8 Organização dos Itens na FFMQ-BR

- Não Julgar — itens 3, 10, 14, 17, 25, 30, 35 e 39; todos invertidos.
- Agir com Consciência: Piloto Automático — itens 8, 23, 28, 34 e 38; todos invertidos.
- Observar — itens 1, 6, 11, 15, 20, 26, 31 e 36; pontuação direta.

- Descrever: Formulação Positiva — itens 2, 7, 27, 32 e 37; pontuação direta.
- Descrever: Formulação Negativa — itens 12, 16 e 22; todos invertidos.
- Não Reagir — itens 4, 9, 19, 21, 24, 29 e 33; pontuação direta.
- Agir com Consciência: Distração — itens 5, 13 e 18; todos invertidos.

9.9 Cálculo

Depois de inverter os 19 itens, somam-se os itens de cada fator. Os intervalos possíveis são:

- Não Julgar — 8 a 40 pontos.
- Agir com Consciência: Piloto Automático — 5 a 25 pontos.
- Observar — 8 a 40 pontos.
- Descrever: Formulação Positiva — 5 a 25 pontos.
- Descrever: Formulação Negativa — 3 a 15 pontos.
- Não Reagir — 7 a 35 pontos.
- Agir com Consciência: Distração — 3 a 15 pontos.

O escore total é obtido pela soma dos 39 itens já corrigidos e varia de 39 a 195 pontos. Para comparação entre fatores com diferentes números de itens, também pode ser útil registrar a média de cada fator, desde que o método adotado seja mantido nas aplicações subsequentes.

Não existem pontos de corte clínicos validados para classificar mindfulness como baixo, médio ou alto.

9.10 Interpretação do Perfil

Uma pontuação mais alta indica maior presença da habilidade representada, depois da inversão dos itens negativos. A interpretação não deve limitar-se ao total. Duas pessoas podem alcançar resultados totais semelhantes e apresentar perfis muito diferentes entre observação, descrição, consciência da ação, não julgamento e não reatividade.

A faceta Observar exige atenção especial. O estudo original mostrou que sua relação com o construto global pode variar conforme a experiência meditativa. Perceber muitos eventos internos e externos não significa necessariamente fazê-lo com aceitação, não julgamento ou capacidade de regulação.

O perfil responde melhor à pergunta “quais habilidades de mindfulness estão mais ou menos disponíveis?” do que à pergunta “a pessoa é mindful ou não?”.

9.11 Uso no Contexto da IPS®

Na IPS®, o FFMQ-BR pode contribuir para acompanhar presença, atenção plena, relação não julgadora com a experiência e capacidade de não reagir automaticamente. Essas dimensões dialogam especialmente com Presença–Agência e com o sexto passo do método, Atenção Plena.

O instrumento complementa a MAIA-2, mas não a substitui. A MAIA-2 enfatiza a relação consciente com sinais corporais e processos interoceptivos; o FFMQ-BR abrange também observação de eventos internos e externos, descrição, qualidade da ação, julgamento e reatividade.

Mudanças nos escores podem ser acompanhadas ao longo da formação ou da intervenção, mas devem ser integradas à entrevista, à observação clínica, à experiência relatada e aos demais instrumentos do programa.

9.12 Limites e Cuidados

- É uma medida de autorrelato de mindfulness disposicional, não um teste de desempenho meditativo.
- Não é instrumento diagnóstico e não possui pontos de corte clínicos validados.
- A estrutura original de cinco facetas e a estrutura brasileira de sete fatores não devem ser apresentadas como se fossem idênticas.
- O estudo brasileiro utilizou análise fatorial exploratória e apresentou evidências iniciais; os próprios autores recomendaram investigações confirmatórias e estudos em outras populações.
- A interpretação da faceta Observar deve considerar experiência meditativa e relação com as demais facetas.
- Escore elevado não comprova prática meditativa, benefício clínico ou mudança causada pela IPS®.

9.13 Implicações para o Aplicador

- Utilizar a versão brasileira correspondente à publicação de Barros e colaboradores.
- Explicar que não existem respostas certas ou erradas.

- Conferir o preenchimento dos 39 itens.
- Aplicar corretamente as 19 inversões.
- Registrar os sete fatores brasileiros e, quando necessário, reuni-los conceitualmente nas cinco facetas originais.
- Não misturar, no mesmo acompanhamento, soma e média sem registrar a mudança de método.
- Interpretar perfil, contexto e evolução, evitando rótulos e pontos de corte inventados.

Considerações Finais

O FFMQ foi concebido como um questionário de cinco facetas de mindfulness. A validação brasileira preservou os 39 itens, mas encontrou sete fatores ao separar formulações positivas e negativas de Descrever e distinguir piloto automático de distração dentro de Agir com Consciência.

Essa diferença deve aparecer claramente no manual. Ela não invalida o modelo original; mostra que a estrutura de um instrumento pode se comportar de maneira específica em outro idioma e contexto cultural.

Fontes Utilizadas Neste Capítulo

Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J. e Toney, L. (2006). Using Self-Report Assessment Methods to Explore Facets of Mindfulness. *Assessment*, 13(1), 27–45. <https://doi.org/10.1177/1073191105283504>

Barros, V. V., Kozasa, E. H., Souza, I. C. W. e Ronzani, T. M. (2014). Validity Evidence of the Brazilian Version of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 30(3), 317–327. <https://doi.org/10.1590/S0102-37722014000300009>

Baer, R. A. Five Facet Mindfulness Questionnaire — formulário e instruções oficiais de pontuação. <https://ruthbaer.com/academics/FFMQ.pdf>

Souza, L. K. e Hutz, C. S. (2013). Questionário das Facetas de Mindfulness. Em C. S. Hutz (org.), *Avaliação em Psicologia Positiva*, pp. 171–173. São Paulo: CETEPP. Citada como publicação brasileira do instrumento, mas não como o estudo psicométrico principal.

GSE

Escala de Autoeficácia Geral

Introdução

A General Self-Efficacy Scale (GSE), de Schwarzer e Jerusalem, avalia a crença geral da pessoa em sua capacidade de lidar de maneira eficaz com dificuldades, acontecimentos inesperados e diferentes situações exigentes. É um instrumento breve, unidimensional e composto por 10 itens.

A escala investiga uma expectativa ampla de competência pessoal. Ela não pergunta apenas se a pessoa deseja mudar, mas em que medida acredita que consegue mobilizar recursos, persistir, encontrar soluções e enfrentar o que surge em seu caminho.

Autoeficácia não é a mudança realizada. É a crença de que se é capaz de organizar e executar ações necessárias para produzir determinados resultados.

10.1 Fundamento Conceitual

O conceito de autoeficácia integra a Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura. Refere-se aos julgamentos que a pessoa faz sobre sua capacidade de realizar ações diante de tarefas, desafios e adversidades. Essas crenças influenciam escolhas, esforço, persistência e modo de responder a obstáculos.

Autoeficácia não é sinônimo de autoestima, otimismo, competência objetiva ou controle absoluto sobre os resultados. Uma pessoa pode possuir recursos e habilidades, mas não acreditar que conseguirá utilizá-los; também pode sentir-se confiante sem dispor ainda de todas as competências necessárias.

A GSE focaliza autoeficácia geral, e não uma capacidade específica. Por isso, oferece uma visão ampla da crença de enfrentamento, mas não substitui medidas específicas quando se deseja avaliar, por exemplo, autoeficácia para atividade física, adesão medicamentosa ou regulação alimentar.

10.2 Origem e Estrutura da GSE

A forma atual da GSE foi apresentada por Schwarzer e Jerusalem em 1995. Possui 10 afirmações, todas formuladas no sentido positivo, e foi concebida para avaliar um senso geral de competência para enfrentar dificuldades cotidianas e adaptar-se a eventos estressantes.

Os itens se organizam em um único fator. Assim, o resultado principal é um escore total: a escala não possui subescalas independentes de persistência, calma, solução de problemas ou manejo de imprevistos, ainda que esses temas apareçam no conteúdo dos itens.

A GSE é unidimensional. Não se devem criar subescalas clínicas a partir de grupos de itens sem estudo psicométrico que sustente essa divisão.

10.3 Qual Versão Está Sendo Utilizada?

O formulário disponibilizado para este manual corresponde à versão portuguesa de Araújo e Moura, publicada em 2011. Essa versão foi estudada em 536 professores de Portugal e utiliza quatro alternativas de resposta.

Há também uma adaptação brasileira publicada por Souza e Souza em 2004, estudada em 283 participantes, com consistência interna de $\alpha = 0,81$. Outro estudo brasileiro, de Sbicigo e colaboradores, avaliou a estrutura da escala em 1.007 adolescentes e encontrou solução unidimensional e $\alpha = 0,85$.

Essas evidências não tornam as versões automaticamente intercambiáveis. O formulário português emprega redação própria de Portugal e respostas de 1 a 4. A publicação brasileira de 2004 descreve respostas de 1 a 5. Portanto, o aplicador deve identificar a versão escolhida, utilizar exatamente suas instruções e manter o mesmo formato em todas as avaliações de uma pessoa.

Não adaptar a linguagem nem alterar a quantidade de respostas durante a aplicação. Qualquer mudança cria uma versão modificada, sem equivalência psicométrica automaticamente assegurada.

10.4 Aplicação da Versão Portuguesa Anexada

No formulário de Araújo e Moura, a pessoa assinala uma resposta para cada uma das 10 afirmações, considerando a maneira como geralmente lida com as situações. As alternativas são:

- 1 — De modo nenhum é verdade.
- 2 — Dificilmente é verdade.
- 3 — Moderadamente verdade.
- 4 — Exatamente verdade.

Todos os itens são pontuados diretamente. Não há itens invertidos. Soma-se a resposta aos 10 itens, produzindo um total entre 10 e 40 pontos. Quanto maior o resultado, maior a autoeficácia geral percebida dentro dessa versão.

Versão portuguesa anexada: 10 itens • respostas de 1 a 4 • nenhum item invertido • escore total de 10 a 40.

10.5 Interpretação

O escore expressa a intensidade relativa da crença geral de autoeficácia. Ele pode ser utilizado para descrever o resultado de uma aplicação e acompanhar mudanças quando o mesmo instrumento, as mesmas instruções e o mesmo sistema de pontuação são mantidos.

A GSE não estabelece diagnóstico e não possui, nas fontes consultadas, pontos de corte clínicos universais para classificar pessoas como portadoras de autoeficácia “baixa”, “média” ou “alta”. A interpretação deve considerar o contexto, a população, a história clínica e a trajetória individual.

Para a IPS®, o uso mais prudente é comparar a pessoa consigo mesma em diferentes momentos. Uma mudança no escore é um dado relevante, mas não comprova isoladamente que a intervenção causou a mudança.

10.6 Autoeficácia e Agência Somatopsíquica

Na IPS®, agência somatopsíquica é a capacidade de efetuar mudanças para o próprio bem-estar por meio de uma ação corporal percebida e intencional. Essa ação pode ocorrer como movimento, gesto, posição, som, respiração, dança, vibração ou mudança sutil de postura.

Autoeficácia e agência somatopsíquica são conceitos relacionados, mas não idênticos. Agência designa a possibilidade de agir e produzir efeitos; autoeficácia descreve a crença de que se é capaz de mobilizar ações para lidar com desafios e alcançar resultados.

A relação clínica pode ser compreendida como uma sequência: a pessoa percebe sua experiência corporal, realiza um movimento orientado por essa percepção, observa o efeito produzido e reconhece que sua ação participou da mudança. Essa experiência pode contribuir para fortalecer a percepção de capacidade pessoal.

A GSE não mede diretamente a agência somatopsíquica. Ela pode ajudar a acompanhar se a crença geral de capacidade se modifica ao longo do processo.

10.7 O Remapeamento como Reconhecimento da Autoeficácia

No protocolo, o remapeamento ocorre depois da agência somatopsíquica. A pessoa interrompe a ação e volta a observar o corpo: o que mudou na localização, intensidade, forma, temperatura, textura, movimento, respiração ou qualidade geral da experiência?

Esse passo torna perceptível a diferença entre o antes e o depois. Seu valor não está em exigir melhora, mas em permitir que a pessoa reconheça com precisão o efeito — ou a ausência de efeito — associado à própria ação.

Quando uma mudança significativa é percebida, o aplicador pode ajudar a pessoa a reconhecer a autoria sem prometer controle total: “Você percebe alguma relação entre o movimento que fez e o que mudou agora?” A experiência deixa de ser apenas algo que aconteceu e passa a ser compreendida como uma ação que produziu consequências observáveis.

Esse reconhecimento se aproxima do que Bandura descreve como experiência de domínio: resultados interpretados como conquistas pessoais tendem a ser uma fonte importante de crenças de eficácia. Entretanto, essa relação é uma formulação clínica da IPS® e não significa que o remapeamento, isoladamente, tenha sido validado como intervenção para elevar o escore da GSE.

Mapear mostra como estou. Agir permite experimentar uma resposta. Remapear permite perceber o que minha ação produziu.

10.8 Do Corpo para a Vida Prática

O fechamento da prática pode favorecer a transferência do aprendizado. Depois de reconhecer uma mudança corporal, o paciente é convidado a identificar qual princípio da experiência pode ser levado para uma situação concreta da vida.

- O que você fez que ajudou a produzir essa mudança?
- Qual foi o menor movimento necessário para algo começar a mudar?
- Em que situação da sua vida essa mesma capacidade pode ser utilizada?
- Qual ação pequena, específica e possível você pode experimentar até o próximo encontro?

- Como você perceberá que sua ação produziu algum efeito?

O objetivo não é generalizar de maneira automática que “se consegui mudar uma sensação, consigo resolver qualquer problema”. A proposta é extrair um aprendizado proporcional e verificável: posso perceber, escolher uma resposta, agir, observar consequências e ajustar o próximo passo.

10.9 Um Ciclo Clínico de Fortalecimento da Autoeficácia

- Percepção — identificar a experiência presente e a necessidade envolvida.
- Escolha — reconhecer possibilidades e selecionar uma ação tolerável.
- Agência — realizar o movimento ou recurso escolhido.
- Remapeamento — observar diferenças entre o estado inicial e o estado atual.
- Atribuição — reconhecer de forma realista a participação da própria ação no resultado.
- Transferência — transformar o aprendizado em um passo concreto na vida cotidiana.
- Reavaliação — observar o resultado, aprender e ajustar a ação seguinte.

A repetição desse ciclo pode ampliar um repertório de experiências nas quais a pessoa se percebe capaz de agir. O aplicador deve valorizar mudanças reais, inclusive pequenas, sem fabricar sucesso quando ele não ocorreu.

10.10 Quando Não Há Mudança no Remapeamento

A ausência de mudança não deve ser interpretada como fracasso, baixa capacidade ou resposta errada. Ela pode indicar que o movimento escolhido não correspondeu à necessidade, que a intensidade foi insuficiente ou excessiva, que o organismo precisa de mais tempo, ou simplesmente que aquela experiência não se modificou naquele momento.

O aplicador pode explorar com curiosidade: o que permaneceu igual, o que ficou mais claro, qual limite foi reconhecido e que ajuste seria seguro experimentar? Perceber que é possível interromper, pedir ajuda ou escolher outra estratégia também pode constituir agência.

Autoeficácia realista não é acreditar que tudo será controlado. É confiar na capacidade de experimentar respostas, aprender com os efeitos e buscar apoio quando necessário.

10.11 Uso da GSE no Acompanhamento da IPS®

A GSE pode ser aplicada antes do início da intervenção e repetida em um momento previamente definido. O intervalo deve ser registrado e mantido sempre que possível. Para interpretar a evolução, o escore deve ser integrado aos relatos de agência, aos registros de prática e às mudanças funcionais observadas na vida cotidiana.

Sugestões de dados complementares:

- Exemplos concretos de ações iniciadas ou retomadas.
- Persistência diante de obstáculos e capacidade de ajustar estratégias.
- Reconhecimento de recursos internos, corporais, relacionais e ambientais.
- Capacidade de transformar insights da prática em próximos passos possíveis.
- Diferenças percebidas entre mapeamento e remapeamento.

A mudança clinicamente relevante pode aparecer no escore, na narrativa e no comportamento. Divergências entre essas fontes são informações para investigação, não erros que precisam ser apagados.

10.12 Limites e Cuidados

- A GSE é uma medida de autorrelato e pode ser influenciada por estado emocional, contexto e desejabilidade social.
- A escala avalia autoeficácia geral, não competências específicas nem agência somatopsíquica diretamente.
- Não utilizar pontos de corte inventados nem transformar o resultado em diagnóstico.
- Não comparar escores provenientes de versões com quatro e cinco alternativas como se fossem equivalentes.
- Não modificar palavras, opções de resposta ou pontuação sem reconhecer que se trata de uma versão alterada.
- Escore maior não comprova benefício clínico, e mudança temporal não demonstra causalidade isoladamente.
- A validação brasileira em adolescentes não deve ser generalizada automaticamente para todas as populações clínicas adultas.

10.13 Implicações para o Aplicador

- Registrar nome, idioma, autoria e versão exata do formulário utilizado.
- Manter as mesmas instruções e alternativas entre as aplicações.
- Conferir se os 10 itens foram respondidos e somá-los sem inversões.
- Interpretar o total em conjunto com entrevista, contexto e evolução individual.
- Explorar no remapeamento mudanças observáveis, sem sugerir que a pessoa deveria melhorar.
- Ajudar o paciente a atribuir realisticamente a participação de sua ação no efeito percebido.
- Traduzir o aprendizado corporal em ação pequena, concreta e verificável na vida prática.

Considerações Finais

A GSE oferece uma medida breve da crença geral de capacidade para lidar com dificuldades. Na IPS®, ela pode dialogar com o percurso entre presença, agência, remapeamento e transferência para a vida cotidiana, desde que seus limites psicométricos sejam preservados.

O remapeamento ocupa uma posição clínica especialmente relevante: ele permite comparar a experiência antes e depois da ação. Quando o paciente reconhece que um movimento seu participou de uma mudança significativa, essa experiência pode ser elaborada como evidência pessoal de capacidade e transformada em um próximo passo possível fora da prática.

Fontes Utilizadas Neste Capítulo

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>

Bandura, A. (1982). Self-efficacy Mechanism in Human Agency. *American Psychologist*, 37(2), 122–147. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122>

Schwarzer, R. e Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy Scale. Em J. Weinman, S. Wright e M. Johnston (orgs.), *Measures in Health Psychology: A User's Portfolio*, pp. 35–37. Windsor: NFER-Nelson.

Souza, I. e Souza, M. A. (2004). Validação da Escala de Auto-Eficácia Geral Percebida. *Revista Universidade Rural: Série Ciências Humanas*, 26(1–2), 12–17.

Araújo, M. e Moura, O. (2011). Estrutura factorial da General Self-Efficacy Scale (Escala de Auto-Eficácia Geral) numa amostra de professores portugueses. *Laboratório de Psicologia*, 9(1), 95–105.

Sbicigo, J. B., Teixeira, M. A. P., Dias, A. C. G. e Dell’Aglío, D. D. (2012). Propriedades Psicométricas da Escala de Autoeficácia Geral Percebida (EAGP). *Psico*, 43(2), 139–146.

Leme, V. B. R., Coimbra, S., Gato, J., Fontaine, A. M. e Del Prette, Z. A. P. (2013). Confirmatory Factor Analysis of the Generalized Self-Efficacy Scale in Brazil and Portugal. *The Spanish Journal of Psychology*, 16, E93. <https://doi.org/10.1017/sjp.2013.93>

IPS-20

Escala de Corporificação IPS®

Introdução

A Escala de Corporificação IPS® (IPS-20) é um instrumento de autorrelato desenvolvido para descrever como a pessoa percebe e integra relações entre corpo, emoção, pensamento, escolha e vida cotidiana. Sua versão 1.0 contém 20 itens distribuídos igualmente em cinco domínios.

O instrumento foi organizado para uso clínico e formativo dentro da IPS®. Seu foco não é apenas a percepção de sensações corporais, mas o percurso pelo qual essas informações são reconhecidas, compreendidas e incorporadas às decisões e ações.

Corporificação, na IPS-20, é observada como um processo de integração: perceber o corpo, relacioná-lo à experiência interna, orientar escolhas e levar mudanças para a vida cotidiana.

11.1 Finalidade do Instrumento

A IPS-20 foi concebida para oferecer um retrato breve da experiência de corporificação nas duas semanas anteriores à aplicação. Os itens abordam cinco movimentos complementares: perceber sinais corporais, relacioná-los às emoções, reconhecer sua interação com pensamentos, utilizá-los nas escolhas e integrar mudanças à vida.

No acompanhamento, a escala pode organizar a conversa clínica, evidenciar áreas mais e menos disponíveis e ajudar a observar mudanças ao longo do processo. Ela não substitui a entrevista, o relato da prática, o mapeamento somatopsíquico nem a observação clínica.

11.2 Estrutura da IPS-20

A escala possui 20 itens, organizados em cinco domínios com quatro itens cada:

- Corpo — itens 1 a 4.
- Emoção — itens 5 a 8.
- Pensamento — itens 9 a 12.

- Escolha — itens 13 a 16.
- Integração — itens 17 a 20.

Cada domínio varia de 0 a 20 pontos. O escore total corresponde à soma dos 20 itens e varia de 0 a 100 pontos. Todos os itens são formulados no mesmo sentido; o documento-fonte não prevê itens invertidos.

IPS-20: 20 itens • cinco domínios • respostas de 0 a 5 • nenhum item invertido • escore total de 0 a 100.

11.3 Domínio Corpo

O domínio Corpo avalia a percepção de sinais corporais e o reconhecimento do corpo como fonte de informação sobre o próprio estado. Inclui perceber sinais antes que se intensifiquem, notar mudanças associadas ao estresse e reconhecer equilíbrio ou desequilíbrio.

- 1. Percebo sinais do meu corpo antes que eles se tornem intensos.
- 2. Consigo notar mudanças corporais relacionadas ao estresse.
- 3. Meu corpo me fornece informações importantes sobre como estou.
- 4. Reconheço quando meu corpo está em equilíbrio ou em desequilíbrio.

Esse domínio dialoga diretamente com a consciência corporal, o primeiro pilar da IPS®, e com o mapeamento somatopsíquico. Seu resultado descreve quanto a pessoa reconhece informações corporais; não determina, isoladamente, a precisão fisiológica dessa percepção.

11.4 Domínio Emoção

O domínio Emoção investiga a capacidade de relacionar sensações corporais a estados emocionais. O foco está em reconhecer emoções por meio de reações do corpo e compreender como sensações físicas e emoções se associam.

- 5. Consigo perceber quais emoções estão associadas às minhas sensações corporais.
- 6. Reconheço emoções através das reações do meu corpo.
- 7. Mudanças em meu corpo me ajudam a compreender meu estado emocional.
- 8. Percebo relações entre minhas emoções e minhas sensações físicas.

Uma pontuação maior indica maior percepção autorrelatada dessa associação. Não significa, por si só, que toda sensação corporal tenha origem emocional ou que a pessoa identifique sempre a emoção de maneira correta.

11.5 Domínio Pensamento

O domínio Pensamento avalia o reconhecimento das relações entre atividade cognitiva e experiência corporal. Abrange perceber efeitos corporais de pensamentos, reconhecer padrões por meio das reações do corpo e identificar corporalmente situações de preocupação excessiva.

- 9. Consigo perceber como determinados pensamentos afetam meu corpo.
- 10. Reconheço padrões de pensamento através das reações corporais.
- 11. Meu corpo me ajuda a identificar quando estou preso em preocupações excessivas.
- 12. As sensações corporais me ajudam a compreender melhor meus pensamentos.

O domínio não avalia a veracidade dos pensamentos nem substitui a investigação cognitiva. Ele descreve a percepção de sua expressão e repercussão corporal.

11.6 Domínio Escolha

O domínio Escolha marca a passagem da percepção para a agência. Ele investiga se as informações corporais participam das decisões, ajudam a reconhecer a necessidade de mudança e se transformam em ação.

- 13. As informações que percebo no corpo influenciam minhas decisões.
- 14. Quando percebo sinais de desequilíbrio consigo ajustar minhas escolhas.
- 15. Meu corpo me ajuda a reconhecer quando preciso mudar algo.
- 16. Consigo agir a partir daquilo que percebo em meu corpo.

Esse domínio se relaciona especialmente ao pilar Presença–Agência. Ainda assim, a pontuação não demonstra que todas as escolhas orientadas pela percepção corporal sejam adequadas; decisões clínicas e cotidianas também exigem contexto, reflexão, valores e avaliação de consequências.

A corporificação não termina na percepção. Ela se torna clinicamente relevante quando amplia a possibilidade de escolha e ação consciente.

11.7 Domínio Integração

O domínio Integração avalia coerência entre sentir, pensar e agir, incorporação de mudanças ao cotidiano, conexão consigo e utilização da percepção corporal como recurso para uma vida mais consciente.

- 17. Percebo coerência entre o que sinto, penso e faço.
- 18. As mudanças que realizei passaram a fazer parte da minha vida cotidiana.
- 19. Sinto-me mais conectado(a) comigo mesmo(a).
- 20. Utilizo a percepção corporal como recurso para viver de forma mais consciente.

Esse domínio amplia a avaliação para além do momento da prática. Ele observa se o aprendiz passou a integrar a vida cotidiana, aproximando corporificação, agência e mudança sustentada.

11.8 Aplicação

A pessoa deve responder considerando sua experiência nas últimas duas semanas. Para cada afirmação, assinala uma alternativa:

- 0 — Nunca.
- 1 — Raramente.
- 2 — Às vezes.
- 3 — Frequentemente.
- 4 — Quase sempre.
- 5 — Sempre.

O aplicador apresenta as instruções de modo neutro, esclarece apenas dúvidas de preenchimento e evita explicar o que seria uma resposta “melhor”. Ao final, confere se os 20 itens foram respondidos.

11.9 Correção

Todos os itens são pontuados diretamente. Calculam-se primeiro os cinco domínios:

- Corpo = itens 1 + 2 + 3 + 4; faixa de 0 a 20.
- Emoção = itens 5 + 6 + 7 + 8; faixa de 0 a 20.
- Pensamento = itens 9 + 10 + 11 + 12; faixa de 0 a 20.

- Escolha = itens 13 + 14 + 15 + 16; faixa de 0 a 20.
- Integração = itens 17 + 18 + 19 + 20; faixa de 0 a 20.

O escore total é obtido pela soma dos 20 itens e varia de 0 a 100. Como todos os domínios possuem o mesmo número de itens e a mesma faixa, seus resultados podem ser apresentados lado a lado para compor o perfil individual.

11.10 Perfil IPS® Proposto na Versão 1.0

O documento da IPS-20 propõe cinco faixas descritivas para o escore total:

- 0 a 20 — Desconectado: pouca percepção das relações entre corpo, emoção, pensamento e comportamento.
- 21 a 40 — Despertando: início do reconhecimento dos sinais corporais e seus significados.
- 41 a 60 — Emergente: maior compreensão da experiência corporal e início de mudanças conscientes.
- 61 a 80 — Integrado: boa capacidade de utilizar a experiência corporal para orientar escolhas.
- 81 a 100 — Corporificado: integração consistente entre corpo, emoção, pensamento, valores e ação.

Essas faixas pertencem ao modelo proposto da IPS-20 v1.0. O material consultado não apresenta estudo de validação que permita tratá-las como pontos de corte clínicos ou normas populacionais.

11.11 Como Interpretar o Perfil com Segurança

O escore total oferece uma síntese, mas a interpretação clínica deve começar pelos cinco domínios. Pessoas com o mesmo total podem apresentar configurações diferentes: uma pode perceber o corpo e as emoções, mas ter dificuldade para transformar essa informação em escolha; outra pode relatar ação e integração com menor clareza emocional.

Os nomes dos perfis devem ser utilizados como descrições do modelo, e não como identidades fixas. A pessoa não “é desconectada” ou “é corporificada”; ela apresentou, naquele período e por autorrelato, um resultado situado em determinada faixa proposta.

Também não se deve concluir que um domínio mais alto seja sempre melhor em qualquer contexto. O resultado precisa ser relacionado à segurança, à flexibilidade, à funcionalidade e à capacidade de integrar informações internas e externas.

11.12 Relação com os Quatro Pilares da IPS®

Os cinco domínios da escala não correspondem diretamente aos quatro pilares da IPS®. Eles descrevem organizações diferentes e não devem ser sobrepostos como se fossem equivalentes.

- Consciência corporal aparece principalmente no domínio Corpo e sustenta os demais.
- Presença-Agência se expressa especialmente na passagem entre percepção, Escolha e ação.
- Conexão-Transcendência pode dialogar com conexão consigo, coerência e valores, mas não é avaliada integralmente por um domínio específico da IPS-20.
- Gratidão-Celebração não constitui domínio próprio da escala e não deve ser inferida diretamente do escore.

A IPS-20 avalia um recorte da corporificação. Ela não pretende representar, sozinha, toda a arquitetura conceitual e experiencial da intervenção.

11.13 Relação com os Sete Passos

A escala pode ajudar a observar capacidades mobilizadas ao longo do protocolo: o mapeamento favorece reconhecimento corporal; a agência transforma percepção em ação; o remapeamento evidencia mudanças; o insight relaciona experiência e significado; a atenção plena sustenta observação; e o fechamento favorece integração e transferência.

Essa correspondência é clínica e conceitual. Cada item não deve ser convertido em medida isolada de um passo, e os resultados não indicam desempenho correto ou incorreto durante a prática.

11.14 Uso Longitudinal

A IPS-20 pode ser aplicada antes da intervenção e repetida em momentos previamente definidos. Para acompanhar uma pessoa, devem ser mantidos o período de referência de duas semanas, as mesmas instruções e o mesmo método de pontuação.

A comparação longitudinal pode considerar:

- Mudança no escore total.
- Mudança em cada um dos cinco domínios.
- Domínios que permaneceram estáveis ou apresentaram evolução desigual.

- Exemplos concretos que sustentam as respostas dadas.
- Convergências e divergências com MAIA-2, FFMQ-BR, GSE e dados clínicos.

Como ainda não foram documentados índices de mudança confiável ou diferença mínima clinicamente importante, qualquer variação deve ser descrita sem afirmar automaticamente melhora clínica significativa.

11.15 Uso na Conversa Clínica

O perfil pode ser devolvido ao paciente como convite à investigação. Perguntas possíveis incluem:

- Qual domínio mais corresponde à forma como você se percebe hoje?
- Que situação concreta ajuda a compreender esse resultado?
- Onde você já percebe algo no corpo, mas ainda não consegue transformar essa informação em escolha?
- Que mudança começou na prática, mas ainda precisa ser integrada à vida cotidiana?
- Qual seria um próximo passo pequeno e seguro para ampliar essa integração?

O objetivo da devolutiva não é convencer o paciente de uma classificação, mas transformar o resultado em linguagem compartilhada para compreensão, escolha e acompanhamento.

11.16 Limites Psicométricos da Versão 1.0

O próprio arquivo de desenvolvimento afirma que a estrutura com 20 itens foi escolhida para facilitar futuras análises psicométricas. No material consultado, não foram apresentados dados de amostra, análise fatorial, consistência interna, estabilidade temporal, validade convergente, sensibilidade à mudança ou normas de interpretação.

Por isso, a IPS-20 deve ser apresentada como instrumento clínico-formativo em desenvolvimento. Até que estudos adequados sejam concluídos, não se pode afirmar que os cinco domínios foram confirmados estatisticamente, que as faixas discriminam níveis clínicos ou que mudanças de pontuação resultem da IPS®.

A ausência de validação não impede o uso exploratório e formativo, mas define os limites das conclusões que podem ser feitas.

11.17 Implicações para o Aplicador

- Utilizar a versão 1.0 sem alterar itens, período de referência ou alternativas de resposta.
- Conferir os 20 itens e somá-los sem inversões.
- Registrar os cinco domínios e o escore total.
- Tratar as faixas como perfis propostos, não como diagnóstico ou ponto de corte validado.
- Evitar transformar nomes de perfis em rótulos pessoais.
- Investigar exemplos concretos que contextualizem cada domínio.
- Integrar os resultados à entrevista, às práticas e aos demais instrumentos.
- Distinguir mudanças observadas de atribuições causais sobre a intervenção.

Considerações Finais

A IPS-20 organiza a corporificação em um percurso clínico inteligível: sentir o corpo, reconhecer suas relações com emoções e pensamentos, utilizar essa informação nas escolhas e integrar mudanças à vida cotidiana. Essa estrutura pode ajudar o aplicador a acompanhar não apenas consciência corporal, mas a passagem da percepção para a ação e para uma vida mais coerente.

Ao mesmo tempo, a escala está em sua versão 1.0 e aguarda investigação psicométrica. Seu valor atual está no uso cuidadoso como mapa clínico-formativo, preservando a distinção entre uma proposta conceitual promissora e um instrumento já validado para decisões clínicas ou comparações normativas.

Fonte Utilizada Neste Capítulo

Escala de Corporificação IPS® (IPS-20), versão 1.0. Material da Mentoria em Psiquiatria Somatopsíquica fornecido para elaboração deste manual.

CONSULTA INDIVIDUAL

Aterrissagem Clínica e Progressão Segura na IPS®

Introdução

A consulta individual em Psiquiatria Somatopsíquica começa pela compreensão da pessoa, e não pela execução do protocolo. Antes de convidar o paciente a voltar-se para o corpo, o aplicador precisa conhecer sua história, sua condição clínica, seus recursos, seus limites e a maneira como ele se relaciona com a experiência corporal.

A introdução dos sete passos deve ser gradual. Na primeira consulta, realiza-se uma anamnese completa e, no máximo, o grounding. Na segunda, se houver segurança e disponibilidade, a prática pode avançar até o remapeamento. Na terceira, os sete passos podem ser conduzidos integralmente apenas se o processo estiver fluindo bem.

O ritmo da IPS® é definido pela segurança e pela capacidade de permanecer presente — não pela necessidade de completar os sete passos.

12.1 Princípios da Consulta Individual

- Conhecer antes de intervir.
- Explicar antes de convidar.
- Solicitar consentimento antes de cada prática.
- Começar com experiências breves e toleráveis.
- Observar a resposta do paciente durante todo o processo.
- Avançar somente quando houver presença, segurança e possibilidade de escolha.
- Pausar, simplificar ou retornar ao grounding diante de desconforto ou insegurança.

A progressão não deve ser utilizada como prova de desempenho. Permanecer mais tempo no grounding pode ser a conduta clinicamente mais adequada e não representa fracasso do paciente ou do aplicador.

12.2 A Primeira Tarefa: Construir Segurança Relacional

A segurança não depende apenas da técnica. Ela também é construída pela atitude do profissional: escuta atenta, linguagem clara, ritmo não apressado, respeito aos limites, ausência de julgamento e abertura para que o paciente diga não, pare ou mude de posição.

Antes de qualquer exercício, o aplicador explica que a prática não exige fechar os olhos, relaxar, produzir uma emoção ou alcançar determinado estado. O paciente pode manter os olhos abertos, movimentar-se, interromper a experiência e informar qualquer desconforto.

O paciente precisa experimentar que continua tendo escolha durante a prática. Essa experiência de autonomia faz parte da segurança.

12.3 Anamnese Completa

A primeira consulta deve ser dedicada prioritariamente à anamnese. O conteúdo e a profundidade da avaliação devem respeitar a formação, a habilitação profissional e o contexto de atuação do aplicador. Para médicos, a consulta inclui avaliação clínica e psiquiátrica completa, exame do estado mental, hipóteses diagnósticas e plano terapêutico quando indicados.

Uma anamnese abrangente deve contemplar, conforme a pertinência clínica:

- Identificação, contexto de vida, ocupação, relações significativas e rede de apoio.
- Queixa principal, motivo da procura, expectativas e objetivos do paciente.
- História do problema atual: início, evolução, fatores precipitantes, agravantes, atenuantes e repercussões funcionais.
- Sintomas emocionais, cognitivos, comportamentais, físicos e relacionados ao sono.
- História psiquiátrica e psicológica: episódios anteriores, diagnósticos, tratamentos, internações e resposta às intervenções.
- Medicamentos atuais e anteriores, adesão, efeitos percebidos e eventos adversos, dentro do escopo profissional.
- História médica, condições clínicas, dor, limitações físicas e necessidades de avaliação adicional.
- Uso de álcool, nicotina, substâncias e outros comportamentos potencialmente compulsivos.
- História familiar de condições clínicas e psiquiátricas relevantes.

- Desenvolvimento, relações familiares, escolaridade, trabalho e acontecimentos importantes da vida.
- Experiências traumáticas ou adversas, investigadas com cuidado, sem pressionar por detalhes desnecessários.
- Hábitos e Medicina do Estilo de Vida: sono, alimentação, atividade física, relações, manejo do estresse, substâncias e sentido de vida.
- Valores, espiritualidade, práticas contemplativas e fontes de significado, quando o paciente autorizar esse tema.
- Recursos pessoais, estratégias de enfrentamento, vínculos seguros e atividades que favorecem estabilidade.
- Avaliação de risco: ideação ou comportamento suicida, autoagressão, risco a terceiros, negligência grave, violência e vulnerabilidades atuais.
- Sinais de psicose, mania, intoxicação, abstinência, dissociação ou desregulação intensa que possam modificar a conduta.

A anamnese não é um interrogatório nem deve ser comprimida para abrir espaço à prática. Se a avaliação clínica exigir toda a consulta, o grounding pode ser deixado para o encontro seguinte.

12.4 Reconhecer a Proximidade do Paciente com o Corpo

Além da história clínica, o aplicador investiga como o paciente percebe, tolera e utiliza informações corporais. O objetivo não é classificá-lo rapidamente, mas compreender sua proximidade atual com o corpo e qual intensidade de prática pode ser segura.

Perguntas exploratórias possíveis:

- Como você percebe que está ansioso, triste, irritado ou seguro?
- É fácil ou difícil notar fome, saciedade, cansaço, tensão, respiração ou batimentos?
- Quando dirige a atenção ao corpo, o que costuma acontecer?
- Você sente curiosidade, neutralidade, medo, vergonha, estranhamento ou desconforto?
- Há partes do corpo das quais costuma se afastar ou que prefere não observar?
- Você percebe os sinais antes que se intensifiquem ou somente quando já estão muito fortes?

- Consegue colocar em palavras o que sente fisicamente?
- Já teve sensação de estar fora do corpo, de que o ambiente não é real ou de perder a noção do presente?
- Que recursos ajudam você a voltar ao aqui e agora?

As respostas podem sugerir proximidade confortável, pouca percepção, hipervigilância, interpretação ameaçadora das sensações ou alternância entre intensidade e desconexão. Nenhum desses padrões deve ser transformado em rótulo. Eles orientam o ritmo, o tipo de convite e a necessidade de estabilização.

12.5 Observação Durante a Conversa

A avaliação da relação com o corpo não depende apenas do que o paciente relata. O aplicador observa, sem interpretar automaticamente, como ele responde quando a atenção se aproxima da experiência corporal.

- Mantém orientação para o ambiente e contato com a conversa?
- Consegue perceber sensações sem ser rapidamente dominado por elas?
- Fica mais presente ou parece afastar-se, congelar ou perder continuidade?
- A respiração torna-se presa, acelerada ou desconfortável?
- Consegue dizer o que prefere, pedir pausa ou recusar um convite?
- Recupera-se quando volta a olhar o ambiente, sentir os pés ou mudar de posição?

Esses sinais devem ser integrados à história clínica. Uma reação corporal isolada não autoriza inferência diagnóstica nem interpretação simbólica automática.

12.6 Primeira Consulta: Anamnese e, no Máximo, Grounding

Objetivo principal: compreender o paciente, estabelecer vínculo, avaliar segurança e reconhecer sua relação inicial com o corpo. A primeira consulta não deve tentar percorrer os sete passos.

Sequência sugerida:

- Acolhimento, apresentação do enquadre e explicação do objetivo da consulta.
- Anamnese completa e avaliação clínica correspondente ao escopo profissional.
- Identificação de riscos, contraindicações, necessidades de estabilização e encaminhamentos.

- Investigação da proximidade com o corpo e dos recursos de segurança já disponíveis.
- Explicação breve da proposta somatopsíquica, sem excesso de teoria.
- Se houver tempo, consentimento e estabilidade: grounding breve.
- Fechamento com checagem do estado atual e orientação do próximo passo.

Primeira consulta: anamnese completa. A prática termina no grounding — e pode não ocorrer se a avaliação clínica precisar de todo o encontro.

12.7 Como Conduzir o Primeiro Grounding

O grounding inicial deve ser simples, breve e orientado ao presente. O aplicador pode convidar o paciente a perceber o apoio da cadeira, o contato dos pés com o chão e elementos visíveis do ambiente. Os olhos podem permanecer abertos.

Durante a prática, usar convites em vez de comandos: “se fizer sentido”, “observe se é confortável”, “você pode parar a qualquer momento”. Evitar aprofundar sensações intensas, solicitar movimentos expressivos ou interpretar conteúdos que surjam.

Ao terminar, perguntar:

- Como você está agora?
- O que foi confortável e o que não foi?
- Você se sente mais presente, igual ou menos presente?
- Há algo de que precisa antes de encerrarmos?

O resultado do primeiro grounding informa o planejamento do encontro seguinte. Uma resposta neutra também é válida; o paciente não precisa sentir relaxamento para que a experiência seja considerada adequada.

12.8 Critérios para Avançar Após a Primeira Consulta

A progressão para o mapeamento e a agência pode ser considerada quando o paciente:

- Compreende a proposta e consente livremente em continuar.
- Permanece orientado e em contato com o ambiente durante o grounding.
- Consegue perceber alguma experiência corporal sem desorganização importante.

- Comunica limites, preferências e desconfortos.
- Recupera estabilidade quando utiliza grounding ou outro recurso.
- Apresenta condição clínica compatível com a prática naquele encontro.

Esses critérios são clínicos e qualitativos. Não constituem uma pontuação formal nem substituem julgamento profissional.

12.9 Segunda Consulta: do Grounding ao Remapeamento

Objetivo principal: apresentar de maneira progressiva os quatro primeiros passos e permitir que o paciente reconheça a diferença entre o estado inicial e o estado após uma ação somatopsíquica.

Antes de iniciar, retomar a semana, revisar a experiência anterior, avaliar o estado atual e confirmar o consentimento. Se houver estabilidade, conduzir:

- Passo 1 — Grounding: estabelecer presença e apoio no ambiente.
- Passo 2 — Mapeamento somatopsíquico: perceber o corpo de modo superficial e, se tolerável, aproximar-se de uma sensação específica.
- Passo 3 — Agência somatopsíquica: permitir movimento, gesto, posição, som ou ajuste corporal que surja da percepção.
- Passo 4 — Remapeamento somatopsíquico: pausar e observar o que mudou, permaneceu ou ficou mais claro.

A prática pode parar em qualquer passo. Se o mapeamento já produzir desconforto crescente, o aplicador não deve avançar para a agência apenas para cumprir a sequência. Retorna-se ao ambiente, aos apoios externos e ao grounding.

Segunda consulta: o limite máximo é o remapeamento. Completar os quatro passos depende da resposta do paciente durante o encontro.

12.10 O Remapeamento como Informação Clínica

O remapeamento não serve para exigir melhora. Ele permite observar a resposta à ação: a sensação mudou de intensidade, localização, temperatura, forma, textura ou movimento? O paciente ficou mais presente, mais distante ou igual?

Quando há mudança, o aplicador pode ajudar o paciente a reconhecer de maneira realista a participação da própria ação. Quando não há mudança, investiga-se o que foi aprendido, qual limite apareceu e que ajuste pode ser necessário. Não se fabrica uma narrativa positiva.

12.11 Critérios para Rodar os Sete Passos

A prática completa pode ser considerada quando os encontros anteriores mostram que o paciente:

- Tolerar grounding, mapeamento, agência e remapeamento sem perder contato com o presente.
- Consegue diferenciar desconforto tolerável de sinais de que precisa parar.
- Mantém possibilidade de escolha e comunicação durante a prática.
- Demonstra curiosidade ou disponibilidade, sem sentir-se coagido a continuar.
- Consegue retornar a um estado suficientemente estável antes do encerramento.
- Não apresenta instabilidade clínica aguda que contraindique o avanço.

“Estar fluindo bem” não significa ausência de emoção. Significa que a experiência pode ser sentida, nomeada e regulada sem perda importante de segurança, orientação ou escolha.

12.12 Terceira Consulta: os Sete Passos, se Houver Segurança

Objetivo principal: integrar os sete passos em uma experiência completa, preservando o direito de interromper, adaptar ou encerrar a prática.

A sequência inclui:

- 1. Grounding.
- 2. Mapeamento somatopsíquico.
- 3. Agência somatopsíquica.
- 4. Remapeamento somatopsíquico.
- 5. Insight.
- 6. Atenção plena.
- 7. Fechamento.

O insight não deve ser induzido nem interpretado pelo aplicador. A atenção plena pode ser breve e adaptada. No fechamento, o paciente relaciona a experiência à sua história, ao momento atual e a um próximo passo possível.

Terceira consulta não significa obrigatoriamente protocolo completo. Ela é o primeiro momento em que os sete passos podem ser considerados, se a trajetória anterior sustentar essa escolha.

12.13 Quando Permanecer Mais Tempo no Grounding

Se o paciente demonstrar insegurança, desconforto ou dificuldade para permanecer presente, dedica-se mais tempo ao grounding antes de avançar. Isso pode ocorrer durante uma parte da consulta ou por vários encontros.

Sinais para desacelerar, pausar ou retornar ao grounding incluem:

- Aumento progressivo de medo, pânico ou sensação de perda de controle.
- Tontura, falta de ar, dor ou mal-estar físico que exijam avaliação.
- Sensação de estar fora do corpo, desrealização, desconexão ou perda de continuidade.
- Congelamento, ausência de resposta ou dificuldade importante para acompanhar a conversa.
- Memórias traumáticas muito vívidas ou invasivas.
- Agitação intensa, desorganização ou incapacidade de recuperar orientação para o ambiente.
- Pedido verbal ou não verbal para parar, afastar-se ou mudar a prática.

Nessas situações, interrompe-se o aprofundamento. O aplicador orienta o paciente para o ambiente, oferece escolhas simples, favorece apoio dos pés e da cadeira e verifica necessidades clínicas imediatas. Sintomas físicos, risco ou deterioração psiquiátrica exigem avaliação e conduta apropriadas, não apenas grounding.

12.14 O Grounding como Tratamento da Base

Grounding não é uma etapa menor nem apenas preparação. Para alguns pacientes, aprender a reconhecer apoio, orientar-se para o ambiente, permanecer no presente e interromper uma prática já constitui trabalho clínico central.

O aprofundamento corporal só é útil quando amplia contato, segurança e escolha. Se a atenção interna aumenta ameaça, hipervigilância ou dissociação, podem ser priorizados recursos externos: visão, audição, contato com superfícies, descrição do ambiente, movimento simples e relação com o profissional.

Primeiro segurança. Depois profundidade. Sem segurança suficiente, aprofundar a experiência corporal pode aumentar desorganização em vez de ampliar consciência.

12.15 Uma Progressão Flexível

A organização em três consultas oferece um mapa inicial, não um cronograma obrigatório:

- Consulta 1 — anamnese completa; no máximo, grounding.
- Consulta 2 — grounding até remapeamento, se houver segurança.
- Consulta 3 — sete passos completos, se o processo estiver fluindo bem.
- Se houver insegurança — permanecer no grounding e nos recursos pelo tempo necessário.

O paciente pode avançar em um encontro e precisar retornar ao grounding no seguinte. Estado clínico, acontecimentos recentes, sono, substâncias, dor, medicação e estressores podem modificar temporariamente sua capacidade de prática.

12.16 Registro Clínico

O registro deve ser objetivo, respeitar sigilo e seguir as normas profissionais aplicáveis. Pode incluir:

- Demanda, dados relevantes da anamnese e avaliação de risco.
- Nível observado de proximidade e tolerância à experiência corporal, descrito sem rótulos.
- Passos explicados, oferecidos e efetivamente realizados.
- Consentimento, adaptações, pausas e preferências do paciente.
- Sensações, emoções e significados relatados pelo próprio paciente.
- Resposta ao grounding e capacidade de retornar ao presente.
- Diferenças percebidas no remapeamento.
- Intercorrências, condutas, encaminhamentos e plano para o próximo encontro.

Evitar registrar interpretações corporais como fatos. Diferenciar claramente observação do profissional, relato do paciente e hipótese clínica.

12.17 Erros a Evitar

- Fazer os sete passos na primeira consulta.
- Reduzir a anamnese para garantir tempo de prática.
- Presumir que fechar os olhos ou focar internamente é seguro para todos.
- Tratar relaxamento como resultado obrigatório do grounding.
- Avançar apesar de insegurança, desconforto crescente ou perda de presença.
- Interpretar movimentos, tensões ou sensações sem confirmação do paciente.
- Transformar a progressão em teste de coragem, adesão ou competência.
- Usar grounding como substituto de avaliação médica, psiquiátrica ou de risco.

12.18 Implicações para o Aplicador

- Chegar à prática depois de compreender a história e o estado atual do paciente.
- Avaliar proximidade com o corpo, tolerância interoceptiva e recursos disponíveis.
- Apresentar escolhas reais e renovar o consentimento ao longo da experiência.
- Observar presença, orientação, respiração, comunicação e capacidade de recuperação.
- Utilizar a sequência de três consultas como referência flexível.
- Permanecer no grounding pelo tempo necessário diante de insegurança.
- Encerrar cada encontro com o paciente suficientemente orientado e estável.
- Manter a IPS® integrada ao cuidado clínico amplo, sem substituir diagnóstico ou tratamento indicado.

Considerações Finais

Na consulta individual, a IPS® não começa quando o paciente fecha os olhos ou percebe uma sensação. Ela começa na anamnese, no vínculo e no reconhecimento de como aquela pessoa se aproxima ou se afasta do próprio corpo.

A progressão ideal é suficientemente lenta para preservar segurança e suficientemente flexível para acompanhar a singularidade do paciente. Primeiro, conhecer e aterrar. Depois, mapear, experimentar

agência e remapear. Somente quando esse percurso estiver seguro e fluido, integrar os sete passos completos.

Fontes Utilizadas Neste Capítulo

Guerra, R. e colaboradores. Detailed Somatopsyche Intervention Protocol. Apêndice do manuscrito da Intervenção Psiquiátrica Somatopsíquica, material da mentoria.

Manual do Aplicador IPS®. Capítulos anteriores, especialmente os quatro pilares, os sete passos, CORAGEM® e os instrumentos de avaliação.

GRUPOS TERAPÊUTICOS

Progressão, Compartilhamento e Aprendizagem Coletiva na IPS®

Introdução

A aplicação grupal da IPS® reúne duas experiências simultâneas: cada participante percorre um processo corporal singular e, ao mesmo tempo, aprende com a diversidade do grupo. O trabalho não busca produzir respostas iguais. Ele oferece uma estrutura comum para que diferentes pessoas possam perceber, transformar, agradecer, celebrar e integrar suas experiências em ritmos próprios.

A progressão deve ser gradual. Na primeira sessão, o grupo realiza grounding e mapeamento superficial. Na segunda, avança do grounding ao remapeamento. A partir da terceira, os sete passos podem ser conduzidos integralmente, desde que o grupo e cada participante apresentem segurança suficiente.

O grupo compartilha uma prática, não um ritmo único. As diferenças de percepção, tempo e resposta fazem parte do processo e constituem uma fonte rica de aprendizagem.

13.1 Avaliação Antes da Entrada no Grupo

Antes do início, cada participante deve ser avaliado individualmente por profissional habilitado, conforme o contexto do programa. Essa avaliação permite conhecer a demanda principal, a condição clínica, os riscos, a proximidade com o corpo, os recursos de segurança e a adequação ao formato grupal.

A entrevista individual também esclarece a proposta, o caráter experiencial das práticas e o direito de adaptar, pausar ou não compartilhar conteúdos pessoais. Questões que exigem investigação reservada não devem ser transferidas para a exposição diante do grupo.

A avaliação prévia não elimina a necessidade de observação contínua. A capacidade de participar pode variar de uma sessão para outra conforme estado clínico, sono, estressores, substâncias, dor, medicação e acontecimentos recentes.

13.2 O Enquadre Grupal

Na primeira sessão, o facilitador estabelece combinados claros:

- Sigilo sobre tudo o que for compartilhado no grupo.
- Respeito e escuta sem interrupções, conselhos automáticos ou interpretações sobre o outro.
- Não julgamento das experiências, movimentos, emoções e ritmos individuais.
- Liberdade para manter os olhos abertos, mudar de posição, pausar ou não realizar um convite.
- Compartilhar apenas o que a pessoa desejar e puder sustentar com segurança.
- Autorresponsabilidade para comunicar desconforto e solicitar ajuda.
- Pontualidade e presença para proteger a continuidade e a segurança do processo.

O facilitador explica que o grupo não deve buscar catarse, desempenho ou exposição. A finalidade é ampliar contato, segurança, escolha e integração.

13.3 Segurança Relacional no Grupo

O modo como o facilitador conduz a experiência ajuda a organizar o campo grupal. Linguagem convidativa, tom de voz estável, instruções breves e ausência de pressa favorecem segurança. O profissional observa o conjunto sem perder de vista cada participante.

Os integrantes devem saber antecipadamente como sinalizar que precisam parar. O facilitador pode combinar um gesto simples ou permitir que a pessoa apenas abra os olhos, mude de posição ou se afaste da prática. Ninguém deve justificar diante do grupo por que interrompeu.

Em grupo, consentimento não é dado uma única vez. Ele é renovado a cada prática e preservado pela possibilidade real de escolher, adaptar ou parar.

13.4 Estrutura Geral de Cada Sessão

Embora o conteúdo varie, uma estrutura estável ajuda os participantes a compreender o processo:

- Chegada e breve verificação do estado atual.
- Retomada da semana e das experiências de prática, quando pertinente.
- Psicoeducação breve sobre o objetivo do encontro.
- Convite para cada participante reconhecer o foco da prática.
- Prática somatopsíquica correspondente à etapa do grupo.
- Pausa para observação e reorganização.

- Compartilhamento voluntário e checagem da compreensão.
- Integração com a vida cotidiana e fechamento.

À medida que o grupo aprende o método, a explicação teórica pode ser reduzida para ampliar o tempo de experiência, compartilhamento e aplicação prática.

13.5 Definir o Foco: Transformação ou Gratidão–Celebração

Antes da prática, o facilitador convida cada integrante a reconhecer o que deseja trabalhar. A pessoa pode escolher o modo Transformação, voltado a algo que deseja compreender ou modificar, ou o modo Gratidão–Celebração, voltado a algo pelo qual se sente grata e que deseja reconhecer e corporificar.

Perguntas possíveis:

- O que você deseja transformar ou compreender melhor hoje?
- Por que você se sente grato neste momento?
- O que deseja agradecer, reconhecer ou celebrar?
- Esse foco parece específico e tolerável para a prática de hoje?

O foco pode ser compartilhado em uma frase, sem relato detalhado. O objetivo é verificar se a pessoa compreendeu o modo escolhido e ajudá-la a tornar a intenção suficientemente concreta para ser levada ao corpo e à prática.

Pedir o foco não significa exigir exposição. Uma palavra ou frase breve pode ser suficiente para orientar a prática e confirmar a compreensão.

13.6 Primeira Sessão: Grounding e Mapeamento Superficial

Objetivo principal: apresentar o enquadre, favorecer segurança e iniciar a aproximação do corpo sem aprofundamento excessivo.

Sequência sugerida:

- Apresentação dos participantes, da proposta e dos combinados.
- Explicação breve sobre consciência corporal, presença e grounding.
- Passo 1 — Grounding: contato com o ambiente, apoios, cadeira, pés e momento presente.

- Passo 2 — Mapeamento superficial: percorrer o corpo de forma ampla, percebendo sensações sem escolher ainda um conteúdo intenso para aprofundar.
- Retorno ao ambiente e checagem do estado atual.
- Compartilhamento voluntário do que foi percebido e de como cada pessoa compreendeu a prática.

Na primeira sessão, não se realiza mapeamento profundo, agência ou remapeamento. O facilitador observa como cada pessoa tolera atenção ao corpo, comunica limites e retorna ao presente.

Primeira sessão: grounding e mapeamento superficial. A prioridade é criar segurança e linguagem corporal compartilhada.

13.7 Compartilhamento Após a Primeira Prática

Após o exercício, o facilitador pode perguntar:

- O que você percebeu no corpo?
- Foi fácil, difícil ou neutro direcionar a atenção às sensações?
- Em algum momento você precisou se afastar, abrir os olhos ou mudar de posição?
- O que ajudou você a permanecer presente?
- Como você explicaria o mapeamento superficial com suas próprias palavras?

As respostas ajudam a verificar compreensão e segurança. O facilitador corrige equívocos com delicadeza, sem hierarquizar experiências ou sugerir que alguém deveria ter sentido mais.

13.8 Segunda Sessão: até o Remapeamento

Objetivo principal: introduzir mapeamento profundo, agência e remapeamento, mantendo grounding e mapeamento superficial como base.

Antes da prática, cada participante é convidado a compartilhar brevemente o que deseja transformar ou aquilo pelo qual se sente grato. Em seguida, se houver segurança, o grupo percorre:

- Passo 1 — Grounding.
- Passo 2 — Mapeamento superficial do corpo.
- Passo 2 — Mapeamento profundo de uma sensação relacionada ao foco escolhido.

- Passo 3 — Agência somatopsíquica por movimento, gesto, posição, som, vibração ou outra resposta tolerável.
- Passo 4 — Remapeamento para reconhecer o que mudou, permaneceu ou ficou mais claro.

Cada integrante pode interromper a sequência em um ponto diferente. Uma pessoa pode permanecer no grounding; outra pode realizar o mapeamento superficial sem aprofundar; outra pode avançar até o remapeamento. Todas continuam pertencendo ao grupo.

Segunda sessão: o limite máximo é o remapeamento. O avanço acontece pessoa a pessoa, e não por obrigação coletiva.

13.9 Compartilhar para Aprender a Colocar em Prática

Depois do remapeamento, o facilitador convida os participantes a descrever, na medida em que desejarem:

- Qual foi o foco escolhido: transformação ou gratidão–celebração?
- Onde esse foco apareceu no corpo?
- Que forma de agência surgiu ou foi escolhida?
- O que mudou ou permaneceu no remapeamento?
- O que compreenderam sobre como utilizar a intervenção?
- Como esse aprendizado pode ser levado para uma situação concreta da vida?

Esse compartilhamento permite identificar se alguém confundiu transformação com supressão, gratidão com obrigação de sentir-se bem, agência com movimento imposto ou remapeamento com exigência de melhora. O facilitador ajuda a ajustar a aplicação sem desautorizar a experiência pessoal.

13.10 A Partir da Terceira Sessão: os Sete Passos

A partir da terceira sessão, os sete passos podem ser conduzidos integralmente quando houver segurança suficiente:

- 1. Grounding.
- 2. Mapeamento somatopsíquico superficial e profundo.
- 3. Agência somatopsíquica.

- 4. Remapeamento somatopsíquico.
- 5. Insight.
- 6. Atenção plena.
- 7. Fechamento.

Antes de cada rodada, os integrantes reconhecem o que desejam transformar ou aquilo pelo qual se sentem gratos. Após a prática, compartilham o que desejarem sobre a experiência, a compreensão do método e sua possível aplicação cotidiana.

O protocolo completo não se torna obrigatório porque o grupo chegou à terceira sessão. Participantes que ainda demonstrem insegurança podem permanecer no grounding ou utilizar apenas os passos que conseguem sustentar.

A partir da terceira sessão, o grupo conhece a sequência completa; cada pessoa continua autorizada a percorrê-la em seu próprio ritmo.

13.11 Dois Modos Dentro do Mesmo Grupo

Em uma mesma sessão, alguns participantes podem escolher o modo Transformação e outros o modo Gratidão–Celebração. Não é necessário que todos trabalhem o mesmo tipo de experiência, desde que as instruções de cada modo sejam compreendidas.

No modo Transformação, o mapeamento se aproxima de algo que a pessoa deseja modificar, e a agência experimenta uma resposta corporal possível. No modo Gratidão–Celebração, o foco é uma experiência de gratidão escolhida pela pessoa, e a agência pode assumir caráter celebrativo. Em ambos, o remapeamento observa o que ocorreu sem exigir um resultado.

Quando necessário, o facilitador pode pedir que cada pessoa nomeie apenas o modo escolhido antes de começar. Isso ajuda a orientar instruções sem expor o conteúdo pessoal.

13.12 Diferenças Individuais como Riqueza do Grupo

Os participantes podem perceber o corpo de maneiras muito diferentes. Alguns identificam sensações rapidamente; outros precisam de mais tempo. Alguns encontram imagens, movimentos ou sons; outros percebem apenas peso, temperatura, tensão ou ausência de sensação. Alguns relatam mudança imediata; outros reconhecem efeitos apenas depois da sessão.

O facilitador explicita que diversidade não significa desigualdade de capacidade. Ouvir experiências distintas amplia o repertório do grupo, normaliza diferentes formas de percepção e mostra que não existe uma única resposta correta.

A riqueza do grupo está na possibilidade de aprender com experiências diferentes sem copiar, competir ou interpretar a experiência do outro.

13.13 Como Facilitar o Compartilhamento

O compartilhamento deve ser organizado para favorecer escuta e evitar comparação. O facilitador pode convidar falas breves em primeira pessoa: “eu percebi”, “eu precisei”, “para mim mudou”. Comentários sobre a experiência de outro participante devem ser evitados, salvo quando a própria pessoa solicitar e o facilitador considerar adequado.

Princípios úteis:

- A participação verbal é convidada, não coagida.
- Silêncio também pode ser uma forma legítima de participação.
- Não interpretar o movimento, a postura ou a emoção do outro.
- Não oferecer conselhos sem solicitação.
- Não transformar intensidade emocional em medida de profundidade.
- Garantir tempo de fala suficientemente distribuído.
- Interromper com cuidado relatos que exponham excessivamente a própria pessoa ou terceiros.

Quando o grupo for numeroso, o compartilhamento pode ocorrer em uma frase por participante, com aprofundamentos reservados para acompanhamento individual quando necessários.

13.14 Checagem de Compreensão

Ao ouvir os participantes, o facilitador verifica se os elementos centrais foram compreendidos:

- Grounding é retorno ao presente e à segurança, não obrigação de relaxar.
- Mapeamento é observação, não interpretação automática da sensação.
- Mapeamento profundo é opcional e depende de tolerância.
- Agência nasce da percepção e não precisa ser intensa ou teatral.
- Remapeamento observa mudança, permanência ou maior clareza.
- Insight não é resposta certa nem interpretação oferecida pelo facilitador.
- Gratidão–Celebração não exige positividade nem apaga sofrimento.
- Fechamento transforma a experiência em aprendizado e próximo passo possível.

A correção deve acontecer na linguagem da prática: esclarecer, demonstrar novamente e oferecer uma nova tentativa segura, sem constranger o participante diante do grupo.

13.15 Quando Alguém Precisa de Mais Grounding

Se um participante demonstrar insegurança, desconforto crescente, perda de orientação, congelamento, dissociação, agitação intensa ou dificuldade para recuperar presença, o facilitador interrompe seu aprofundamento e o ajuda a retornar ao ambiente e aos apoios externos.

O restante do grupo pode continuar apenas se houver condições para que o participante receba atenção adequada e a segurança coletiva seja preservada. Quando isso não for possível, a prática é pausada para todos.

Após a sessão, deve haver avaliação individual do ocorrido e definição do plano: adaptação, permanência no grounding, acompanhamento adicional ou outra conduta clínica indicada. Grounding não substitui manejo de risco ou avaliação médica e psiquiátrica.

13.16 Manejo das Comparações

Comparações podem surgir: “a outra pessoa sentiu e eu não”, “todos se movimentaram menos eu”, “minha mudança foi pequena”. O facilitador deve recolocar a atenção no processo individual.

Respostas possíveis:

- O que aconteceu com você é a informação disponível hoje.
- Não perceber também é algo que podemos observar com curiosidade.
- Você não precisa repetir o movimento de outra pessoa.
- Uma mudança pequena ou nenhuma mudança não invalida a prática.
- Seu ritmo pode ser diferente e continuar legítimo.

O grupo não deve premiar relatos mais intensos, movimentos mais expressivos ou mudanças mais rápidas.

13.17 Aplicação Entre as Sessões

Ao final, cada participante pode identificar uma prática breve ou um aprendizado para levar à semana. O convite deve ser proporcional à etapa do grupo: grounding e percepção superficial após a primeira sessão; uso cuidadoso de agência e remapeamento após a segunda; e integração dos sete passos após a terceira, conforme orientação do programa.

Perguntas de fechamento:

- O que desta sessão faz sentido levar para sua vida?
- Em que situação você poderia utilizar grounding?
- Que sinal corporal deseja aprender a reconhecer mais cedo?
- Qual ação pequena pode nascer do que percebeu hoje?
- O que deseja recordar, agradecer ou celebrar durante a semana?

Não se deve orientar prática autônoma profunda quando o participante ainda depende de apoio para permanecer seguro e presente.

13.18 Registro do Grupo

O registro deve seguir normas profissionais e proteger a privacidade. Pode incluir o conteúdo geral da sessão, passos realizados, adaptações, resposta global do grupo, intercorrências, condutas e plano do encontro seguinte. Informações individuais clinicamente relevantes devem ser registradas de modo apropriado, sem reproduzir desnecessariamente relatos íntimos dos demais participantes.

O facilitador também pode registrar quais aspectos do método exigiram nova explicação. Isso permite ajustar a psicoeducação e verificar se o grupo está pronto para avançar.

13.19 Erros a Evitar

- Introduzir os sete passos completos na primeira sessão.
- Avançar todo o grupo porque a maioria parece pronta.
- Obrigar participantes a revelar o foco ou detalhes íntimos.
- Interpretar movimentos e sensações diante do grupo.
- Tratar experiências semelhantes como superiores às experiências diferentes.
- Confundir gratidão com positividade obrigatória.
- Confundir transformação com eliminação imediata do desconforto.
- Permitir conselhos, diagnósticos ou interpretações entre participantes.
- Ignorar sinais individuais de insegurança para preservar o cronograma coletivo.

13.20 Implicações para o Aplicador

- Realizar avaliação individual antes da entrada no grupo.
- Estabelecer sigilo, não julgamento, autorresponsabilidade e liberdade de escolha.
- Na primeira sessão, limitar a prática ao grounding e mapeamento superficial.
- Na segunda, avançar no máximo até o remapeamento.
- A partir da terceira, oferecer os sete passos sem torná-los obrigatórios para todos.
- Pedir que cada pessoa reconheça o que deseja transformar ou agradecer-celebrar.
- Usar o compartilhamento para verificar compreensão e favorecer aplicação cotidiana.

- Acolher diferenças como parte constitutiva e enriquecedora do processo grupal.
- Interromper ou adaptar a prática sempre que a segurança individual ou coletiva exigir.

Considerações Finais

Nos grupos terapêuticos, a IPS® combina uma estrutura progressiva com trajetórias singulares. O grupo começa pela base comum do grounding e do mapeamento superficial, amplia a experiência até agência e remapeamento e, a partir da terceira sessão, pode integrar os sete passos.

O compartilhamento ajuda os participantes a compreender o método, transformar a experiência em prática e aprender com perspectivas diferentes. A função do facilitador é preservar segurança, escolha e não julgamento para que a diversidade do grupo se torne recurso — e não comparação.

Fontes Utilizadas Neste Capítulo

Guerra, R. e colaboradores. Detailed Somatopsychic Intervention Protocol. Apêndice do manuscrito da Intervenção Psiquiátrica Somatopsíquica, material da mentoria.

Manual do Aplicador IPS®. Capítulos sobre os quatro pilares, os sete passos, consulta individual e instrumentos de avaliação.

INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Para Quem, Quando e em Que Condições Aplicar a IPS®

Introdução

A IPS® foi concebida como uma intervenção corpo-mente transdiagnóstica, voltada a processos presentes em diferentes condições e também no desenvolvimento do bem-estar. Sua indicação não depende apenas de um diagnóstico. Depende dos objetivos da pessoa, de sua estabilidade clínica, da capacidade de participar com segurança e da adequação do formato individual ou grupal.

Em princípio, pode ser considerada para pessoas que desejam melhorar regulação emocional, resiliência, tomada de decisões e receber apoio para mudanças de hábitos e estilo de vida. Entretanto, a IPS® ainda se encontra em processo de validação empírica; portanto, essas finalidades devem ser apresentadas como objetivos do modelo, e não como benefícios clínicos já comprovados para todas as populações.

A indicação nasce do encontro entre objetivo, estabilidade, consentimento, capacidade de participação e qualificação do profissional — não apenas do nome do diagnóstico.

14.1 Indicações Gerais

A IPS® pode ser oferecida a pessoas clinicamente estáveis que desejem:

- Desenvolver maior consciência corporal e reconhecer sinais internos com mais clareza.
- Melhorar a regulação emocional.
- Ampliar presença e capacidade de responder com menor automatismo.
- Fortalecer resiliência diante de dificuldades e mudanças.
- Utilizar informações corporais como apoio à tomada de decisões.
- Reconhecer recursos internos, relacionais e ambientais.
- Desenvolver agência e percepção de autoeficácia.
- Receber apoio para iniciar ou sustentar mudanças de hábitos.
- Integrar mudanças relacionadas ao sono, alimentação, atividade física, manejo do estresse, relações e outros pilares do estilo de vida.

- Cultivar gratidão, celebração, conexão, sentido e maior coerência entre sentir, pensar e agir.

A indicação pode existir tanto na presença de sofrimento emocional quanto em processos de promoção de saúde e desenvolvimento pessoal, desde que o aplicador atue dentro de sua habilitação e saiba reconhecer situações que exigem avaliação ou tratamento especializado.

14.2 A IPS® como Intervenção Complementar

A IPS® não substitui avaliação diagnóstica, psicoterapia indicada, tratamento medicamentoso, manejo de crise, acompanhamento médico ou intervenções específicas com eficácia estabelecida. Quando utilizada em pessoas com transtornos mentais, deve integrar um plano de cuidado mais amplo.

Em psicose e transtorno bipolar, diretrizes clínicas recomendam tratamentos farmacológicos e intervenções psicológicas específicas, conduzidas por profissionais competentes e ajustadas à fase da doença. A IPS® não deve ser apresentada como alternativa a esses cuidados.

Adicionar a IPS® ao cuidado não autoriza retirar, reduzir ou modificar outros tratamentos sem avaliação do profissional responsável.

14.3 Condições para uma Boa Indicação

Antes de iniciar, o aplicador verifica se a pessoa:

- Compreende a proposta e pode consentir de forma livre e informada.
- Está suficientemente orientada e clinicamente estável para participar.
- Consegue comunicar desconforto, limites e necessidade de pausa.
- Apresenta algum recurso para retornar ao presente, ainda que precise aprendê-lo com grounding.
- Possui objetivos compatíveis com a proposta da intervenção.
- Pode comparecer ao acompanhamento e utilizar o formato proposto com segurança.
- Recebe cuidado adicional quando sua condição clínica assim exige.

A ausência inicial de familiaridade com o corpo não contraindica a IPS®. Ela indica a necessidade de começar lentamente, com grounding, mapeamento superficial e avaliação contínua da tolerância.

14.4 Indicação para o Formato Grupal

O grupo pode ser indicado quando a pessoa, além dos critérios gerais:

- Consegue respeitar sigilo, limites e diferenças entre participantes.
- Tolerar compartilhar espaço, atenção e tempo de fala.
- Compreende que o compartilhamento é voluntário e não exige exposição íntima.
- Pode seguir instruções coletivas sem perder a possibilidade de fazer adaptações individuais.
- Apresenta estabilidade suficiente para que suas necessidades possam ser manejadas no enquadre grupal.

O formato grupal oferece identificação, diversidade de perspectivas e aprendizagem compartilhada. No entanto, não deve ser escolhido quando a pessoa necessita de observação contínua, adaptações intensivas ou manejo individual que o grupo não consegue oferecer.

14.5 Regra da IPS® para Psicose e TAB Tipo I em Grupos

Por decisão clínica conservadora do método, pessoas com transtornos psicóticos ou Transtorno Afetivo Bipolar tipo I não participam dos grupos terapêuticos da IPS®. Essa regra busca proteger o participante e o grupo diante da possibilidade de desorganização, oscilação do estado mental ou necessidade de manejo especializado e individualizado.

Essa é uma regra operacional específica dos grupos IPS®. Ela não significa que pessoas com psicose ou TAB I não possam participar de nenhuma intervenção psicológica em grupo. Diretrizes atuais reconhecem intervenções psicológicas e psicossociais em ambas as condições quando apropriadas, estruturadas e conduzidas por profissionais competentes.

Grupos IPS®: psicoses e TAB tipo I são contraindicações segundo a regra do método, ainda que a pessoa esteja estável.

14.6 Possibilidade de Atendimento Individual

Pessoas com diagnóstico de transtorno psicótico ou TAB tipo I podem ser consideradas para IPS® individual quando o médico condutor for psiquiatra, houver avaliação clínica completa e o paciente não estiver em episódio psicótico ou maníaco agudo.

O psiquiatra deve integrar a prática ao tratamento do transtorno, avaliar estado mental, risco, sono, uso de substâncias, adesão medicamentosa, sinais prodrômicos e rede de apoio. O protocolo pode exigir progressão mais lenta, maior tempo de grounding, sessões mais breves e monitoramento intensivo.

Quando houver outros profissionais na equipe, a coordenação do cuidado e a comunicação autorizada pelo paciente devem ser definidas. A IPS® individual permanece complementar e não substitui tratamento baseado em evidências para psicose ou transtorno bipolar.

Psicose ou TAB I em atendimento individual: somente com condução médica de psiquiatra, estabilidade clínica e adaptação do protocolo.

14.7 Contraindicação Durante Episódios Agudos

A IPS® não deve ser iniciada nem aprofundada durante psicose aguda ou episódio maníaco agudo. Nesses estados, a exploração corporal e subjetiva intensa pode aumentar desorganização, e a prioridade clínica é avaliação psiquiátrica, segurança e tratamento do episódio.

Também se deve adiar a prática diante de:

- Suspeita de mania ou agravamento importante de sintomas psicóticos.
- Risco iminente de suicídio, autoagressão ou violência.
- Intoxicação, abstinência clinicamente relevante ou alteração importante da consciência.
- Delirium, confusão aguda ou condição médica que exija investigação imediata.
- Incapacidade atual de compreender a proposta ou consentir de forma válida.
- Desorganização ou agitação que impeça seguir instruções simples e recuperar orientação para o ambiente.

Essas situações exigem avaliação e manejo apropriados. Grounding pode ser utilizado apenas se fizer parte de uma conduta clínica segura e não atrasar o atendimento necessário.

Episódio psicótico ou maníaco agudo: contraindicação temporária à IPS®, inclusive quando o condutor é psiquiatra.

14.8 Psicose: Diagnóstico não é Igual a Estado Agudo

Ter um transtorno psicótico na história não equivale a estar psicótico no momento. A decisão individual deve considerar fase clínica, sintomas atuais, funcionamento, insight, tratamento, riscos e capacidade de manter presença e escolha.

Em período subagudo, pós-crise ou de estabilidade, o psiquiatra pode avaliar uma aplicação individual adaptada. A aproximação deve começar por grounding e orientação ao ambiente; práticas internas prolongadas, silêncio extenso ou aprofundamento de experiências ambíguas exigem cautela.

O aplicador não deve validar interpretações delirantes, atribuir significado espiritual automático a sintomas ou estimular exploração que aumente confusão entre experiência interna e realidade compartilhada.

14.9 TAB Tipo I: Diagnóstico não é Igual a Mania Atual

O diagnóstico de TAB I indica história de pelo menos um episódio maníaco, mas o paciente pode estar eutímico, deprimido ou em outra fase clínica. Para atendimento individual, o psiquiatra avalia especialmente sono, energia, aceleração, irritabilidade, impulsividade, grandiosidade, psicose, uso de substâncias e mudanças recentes de medicação.

Se surgirem sinais de hipomania, mania ou deterioração clínica, a prática deve ser interrompida ou simplificada e o plano terapêutico revisto. Exercícios muito ativadores, movimentos intensos ou experiências celebrativas expansivas podem exigir adaptação mesmo fora de um episódio plenamente caracterizado.

14.10 Situações que Exigem Adaptação, não Exclusão Automática

Algumas condições não são contraindicações absolutas, mas pedem avaliação individual, progressão gradual e maior acompanhamento:

- Sintomas dissociativos ou história de despersonalização e desrealização.
- História de trauma e dificuldade de permanecer em contato com o corpo.
- Pânico ou interpretação catastrófica de sensações corporais.
- Desregulação emocional intensa.
- Alexitimia ou dificuldade importante para reconhecer e nomear estados internos.

- Dor crônica, limitações físicas ou condições médicas que exijam adaptação de postura e movimento.
- Transtornos alimentares, uso de substâncias ou comportamentos compulsivos em acompanhamento.
- Condições do neurodesenvolvimento com necessidades sensoriais ou comunicacionais específicas.

Nesses casos, podem ser utilizados olhos abertos, foco exteroceptivo, práticas curtas, movimentos pequenos, menos silêncio e acompanhamento individual mais próximo. A adaptação deve ser guiada pela resposta real da pessoa, não por uma fórmula única.

14.11 Quando Preferir o Atendimento Individual

Mesmo sem psicose ou TAB I, o formato individual pode ser preferível quando há:

- Necessidade de anamnese ou avaliação clínica mais extensa.
- Vergonha, exposição ou ansiedade grupal que inviabilizem participação segura.
- Trauma, dissociação ou hipervigilância que requeiram progressão muito personalizada.
- Limitações físicas, sensoriais ou comunicacionais que demandem adaptações contínuas.
- Risco ou instabilidade que necessitem monitoramento mais próximo, sem configurar episódio agudo que contraindique a prática.
- Dificuldade para manter sigilo, respeitar limites ou acompanhar o enquadre coletivo.

A escolha do individual não deve ser apresentada como punição ou exclusão. Ela pode ser a forma mais segura de preservar vínculo, singularidade e continuidade do cuidado.

14.12 Quando Pausar uma IPS® já Iniciada

A indicação deve ser reavaliada ao longo do acompanhamento. Pausar e encaminhar para avaliação é necessário quando surgem:

- Sintomas psicóticos novos ou agravamento de sintomas preexistentes.
- Redução importante da necessidade de sono, aceleração, agitação ou outros sinais de mania.
- Aumento de risco suicida, autoagressivo ou heteroagressivo.
- Dissociação persistente ou piora após as práticas.
- Desorganização, confusão ou incapacidade de recuperar presença.

- Sintomas físicos relevantes que exijam avaliação médica.
- Uso de substâncias que comprometa segurança e participação.

A pausa não determina necessariamente encerramento definitivo. Após estabilização e nova avaliação, o psiquiatra responsável pode decidir se existe indicação de retomada individual e em que condições.

14.13 Decisão Clínica por Formato

- Pessoa clinicamente estável, sem psicose ou TAB I, com objetivos compatíveis — grupo ou individual, conforme avaliação e preferência.
- Psicose ou TAB I, mesmo em estabilidade — não participar dos grupos IPS®; considerar apenas individual com psiquiatra.
- Psicose aguda ou mania aguda — não realizar IPS®; priorizar avaliação, segurança e tratamento do episódio.
- Trauma, dissociação ou desregulação sem episódio agudo — considerar individual ou grupo com adaptação, conforme tolerância e recursos.
- Risco iminente, delirium, intoxicação ou incapacidade de consentir — adiar IPS® e realizar manejo clínico apropriado.

Formato e intensidade são decisões clínicas dinâmicas. O paciente pode precisar mudar de grupo para individual, pausar ou retornar ao grounding conforme sua evolução.

14.14 Como Explicar uma Contraindicação ao Paciente

A contraindicação deve ser comunicada sem estigma. O profissional explica que a decisão se refere à segurança naquele formato ou momento, não ao valor, à capacidade ou à possibilidade de recuperação da pessoa.

Exemplo de formulação: “Esta prática pode aprofundar a atenção à experiência interna. Neste momento, precisamos priorizar sua estabilidade e um acompanhamento mais individualizado. Isso não significa que você falhou; significa que vamos escolher o cuidado mais seguro agora.”

Quando possível, oferecer um próximo passo concreto: avaliação psiquiátrica, ajuste do plano de cuidado, atendimento individual, acompanhamento mais intensivo ou reavaliação após estabilização.

14.15 Limites da Evidência

O manuscrito teórico descreve a IPS® como uma abordagem promissora e ainda em validação. Não há, no material consultado, ensaios clínicos que permitam afirmar eficácia para todas as indicações listadas ou estabelecer segurança específica em psicose e TAB I.

Por isso, as indicações deste capítulo expressam objetivos e usos clínico-formativos do modelo. As contraindicações e adaptações refletem o manuscrito da IPS®, princípios de segurança e a política clínica do método. Devem ser revistas à medida que novos estudos forem publicados.

14.16 Implicações para o Aplicador

- Avaliar objetivo, estabilidade, consentimento e capacidade de participação antes de indicar.
- Apresentar a IPS® como complementar e ainda em processo de validação.
- Não admitir psicose ou TAB I nos grupos IPS®.
- Atender psicose ou TAB I individualmente apenas quando o condutor for psiquiatra e houver estabilidade.
- Não realizar IPS® durante psicose aguda ou mania aguda.
- Reconhecer risco, intoxicação, delirium e incapacidade de consentir como motivos para adiamento e manejo específico.
- Adaptar progressão em trauma, dissociação, desregulação e condições clínicas relevantes.
- Reavaliar a indicação a cada encontro e documentar decisões, adaptações e encaminhamentos.

Considerações Finais

A IPS® pode ser indicada a pessoas que desejem desenvolver regulação emocional, resiliência, tomada de decisões e apoio à mudança de hábitos e estilo de vida. Sua proposta ampla não elimina a necessidade de seleção clínica cuidadosa.

Para os grupos IPS®, psicoses e TAB tipo I são contraindicações segundo a regra do método. No atendimento individual, esses diagnósticos podem ser considerados apenas por psiquiatra e fora de episódios agudos. Em psicose ou mania aguda, a prioridade é estabilização e tratamento apropriado — não a realização do protocolo.

Fontes Utilizadas Neste Capítulo

Guerra, R. F. e Tavares, H. Theory and Conception of Somatopsychic Psychiatric Intervention: A Transdiagnostic Body–Mind Intervention for Psychiatric Practice. Manuscrito da IPS® utilizado para objetivos, estabilidade clínica, adaptações e restrição em estados psicóticos ou maníacos agudos.

National Institute for Health and Care Excellence — NICE. Bipolar disorder: assessment and management. Guideline CG185, atualizada em 2025. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg185>

National Institute for Health and Care Excellence — NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. Guideline CG178. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg178>

World Health Organization. mhGAP Intervention Guide, version 2.0: psychoses and manic episode in bipolar disorder. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790>

Ellett, L. e Chadwick, P. (2021). Recommendations for monitoring and reporting harm in mindfulness for psychosis research. *British Journal of Psychiatry*, 219(6), 629–631. <https://doi.org/10.1192/bjp.2021.98>

MUDANÇA DE HÁBITOS E MEDICINA DO ESTILO DE VIDA

Prontidão Somatopsíquica para Mudança com os Sete Passos e o C.O.R.A.G.E.M.®

Introdução

Mudar não é apenas saber o que fazer. Uma pessoa pode compreender a recomendação, desejar o resultado e, ainda assim, não conseguir iniciar ou sustentar a ação. Entre intenção e comportamento existem corpo, emoção, resistência, contexto, sentido, recursos, confiança e oportunidade real.

Na perspectiva da IPS®, a mudança torna-se mais possível quando deixa de ser apenas uma ordem cognitiva e passa a ser uma experiência corporificada. A pessoa reconhece como está, aproxima-se do que a mobiliza ou bloqueia, experimenta uma resposta, observa seus efeitos e transforma esse aprendizado em um passo concreto.

Prontidão somatopsíquica para mudança é a disponibilidade integrada para perceber, sustentar, escolher e realizar um próximo passo possível, com presença no corpo, sentido, agência e respeito ao contexto.

15.1 Uma Formulação Própria da IPS®

Prontidão somatopsíquica para mudança é uma formulação clínica da IPS®. Neste manual, o termo descreve um estado dinâmico no qual a pessoa dispõe de contato suficiente consigo, segurança, clareza, significado e agência para aproximar-se de uma mudança possível.

Não se trata de diagnóstico, traço fixo, estágio universal nem instrumento psicométrico validado separadamente. A prontidão pode variar conforme o comportamento, o momento, o ambiente, os recursos e a intensidade da questão. Alguém pode estar pronto para conversar sobre uma mudança, mas ainda não para executá-la; pronto para um pequeno teste, mas não para uma transformação ampla.

15.2 Por que Intenção não Basta

A literatura sobre mudança comportamental mostra uma distância consistente entre intenção e ação. Em uma meta-análise experimental, mudanças de magnitude média a grande na intenção produziram

mudanças menores no comportamento. Desejar, compreender ou prometer uma mudança não garante sua realização.

A IPS® acrescenta uma pergunta clínica: como essa intenção existe no corpo e na vida concreta desta pessoa? Uma intenção pode coexistir com medo, congelamento, exaustão, conflito de valores, pouca confiança, ausência de apoio ou impedimentos ambientais. Ignorar esses elementos favorece prescrição sem adesão e culpa sem aprendizagem.

15.3 Os Componentes da Prontidão Somatopsíquica

- Segurança suficiente — capacidade de permanecer em contato com a experiência sem perda importante de organização, consentimento ou presença.
- Consciência corporal — reconhecimento de sensações, mobilização, retraimento, necessidades e limites relacionados à mudança.
- Presença — contato com o momento atual, com o ambiente, consigo e com o outro.
- Significado — clareza sobre por que a mudança importa e quais valores, necessidades ou propósitos a sustentam.
- Agência — percepção de que existe alguma resposta possível, ainda que pequena, e possibilidade de participar do processo.
- Autoeficácia realista — confiança proporcional na capacidade de experimentar, aprender, ajustar e pedir ajuda.
- Contexto favorável ou negociável — recursos, oportunidade, apoio e redução possível de barreiras externas.
- Gentileza e flexibilidade — capacidade de aprender com dificuldades sem converter tropeços em condenação pessoal.

Esses componentes não formam uma lista de exigências que precisa estar perfeita. Eles orientam a investigação clínica e ajudam a descobrir o que precisa ser fortalecido antes de pedir uma ação maior.

15.4 Os Quatro Pilares como Base da Mudança

- Consciência corporal — torna perceptíveis o estado atual, as necessidades, a resistência e os sinais de aproximação ou afastamento.

- Presença-agência — cria espaço entre automatismo e resposta, permitindo experimentar escolha e autoria.
- Conexão-transcendência — liga a mudança a valores, vínculos, propósito e algo maior do que a exigência imediata.
- Gratidão-celebração — reconhece recursos e consolida pequenos movimentos, sem negar dificuldade nem fabricar positividade.

A prontidão emerge da integração desses pilares. O corpo informa; a presença permite permanecer; a agência ensaia uma resposta; a transcendência oferece direção; e a celebração ajuda a reconhecer o caminho percorrido.

15.5 Resistência não é Falta de Vontade

Resistência pode aparecer como procrastinação, medo, distração, ambivalência, cansaço, esquecimento, racionalização, congelamento ou adiamento. Ela não deve ser automaticamente interpretada como oposição, preguiça ou ausência de compromisso.

Clinicamente, a resistência pode proteger de ameaça, perda, vergonha, fracasso, conflito relacional ou exigência excessiva. Também pode indicar que a ação proposta é grande, pouco autêntica, incompatível com o contexto ou ainda não foi incorporada como escolha da pessoa.

A resistência não é um inimigo a vencer. É uma informação a reconhecer para que a mudança encontre tamanho, ritmo e direção possíveis.

15.6 O Papel dos Sete Passos

Os sete passos oferecem a arquitetura experiencial da prontidão somatopsíquica. Eles não empurram diretamente para a meta; preparam condições para que uma resposta mais integrada possa aparecer.

- 1. Presença e grounding — favorecem segurança, orientação e contato com o aqui e agora.
- 2. Mapeamento somatopsíquico — revela como a mudança desejada, a resistência ou o conflito aparecem no corpo.
- 3. Agência somatopsíquica — permite experimentar movimento, gesto, postura, som ou outra resposta corporal possível.

- 4. Remapeamento — torna observáveis mudanças, permanências, limites e efeitos da ação realizada.
- 5. Insight — aproxima a experiência de palavras, imagens, valores, necessidades e compreensão.
- 6. Atenção plena — oferece espaço para integração, sem julgamento e sem pressa de concluir.
- 7. Fechamento — relaciona a experiência à história, ao momento atual e ao próximo passo na vida prática.

A prontidão não é presumida no início. Ela pode ser construída durante o percurso. Às vezes, o resultado dos sete passos não será “agir agora”, mas reconhecer que é necessário reduzir a intensidade, buscar apoio, reunir recursos ou reformular a meta.

15.7 O Remapeamento como Evidência Experiencial

No remapeamento, a pessoa observa o que ocorreu depois de sua ação: o que mudou, o que permaneceu, o que se tornou mais claro e qual foi o limite encontrado. Quando percebe relação realista entre o movimento realizado e uma alteração significativa, pode reconhecer que participou do resultado.

Esse reconhecimento aproxima-se de uma experiência de domínio, uma das fontes de autoeficácia descritas por Bandura. Na IPS®, essa é uma formulação clínica: o remapeamento pode favorecer percepção de capacidade, mas não foi validado isoladamente como técnica para elevar autoeficácia.

Mapear mostra como estou. Agir permite experimentar uma resposta. Remapear permite reconhecer o que minha ação produziu. Fechar transforma o aprendizado em vida prática.

15.8 C.O.R.A.G.E.M.® : da Prontidão ao Movimento Sustentável

O C.O.R.A.G.E.M.® organiza a passagem entre a experiência integrada e a continuidade da mudança. Os sete passos ajudam a pessoa a escutar, experimentar e compreender; o C.O.R.A.G.E.M.® ajuda a sustentar direção, atravessar resistência e realizar uma ação concreta com autenticidade e gentileza.

- C — Coração: por que isso é importante para mim? Qual valor, paixão ou propósito está por trás desta ação?
- O — Oração ou conexão com algo maior: como espiritualidade, valores, natureza, silêncio ou consciência podem me sustentar neste passo?

- R — Resistência: como ela aparece — medo, procrastinação, distração, desânimo ou “depois eu faço”?
- A — Ação: qual é a primeira ação possível agora? Não precisa ser perfeita; precisa existir.
- G — Gentileza: como posso me tratar como trataria alguém querido e reconhecer meu esforço?
- E — Emergir: o que é autêntico para mim aqui? O que começa a aparecer depois que inicio a ação?
- M — Momento a Momento: estou presente comigo, com o outro e com o contexto? Consigo lembrar que mudança é processo, não evento?

15.9 Como os Dois Percursos se Articulam

Os sete passos e o C.O.R.A.G.E.M.[®] não são sequências concorrentes. Eles cumprem funções complementares e podem ser articulados sem misturar suas identidades.

- Os sete passos aprofundam a experiência: presença, mapeamento, agência, remapeamento, insight, atenção plena e fechamento.
- O C.O.R.A.G.E.M.[®] organiza a sustentação da mudança: valor, transcendência, resistência, ação, gentileza, autenticidade e continuidade.

Uma forma de integração é concluir os sete passos e, no fechamento, utilizar o C.O.R.A.G.E.M.[®] para transformar o aprendizado em plano. Outra possibilidade é usar o C.O.R.A.G.E.M.[®] antes da prática para identificar a mudança e a resistência, escolhendo então o tema que será levado aos sete passos.

15.10 Um Ciclo Clínico Integrado

- 1. Escolher uma mudança específica e de intensidade tolerável.
- 2. Investigar sentido, ambivalência, contexto, recursos e segurança.
- 3. Realizar os sete passos com a questão escolhida.
- 4. Reconhecer no remapeamento o efeito, a ausência de efeito e os limites da ação.
- 5. No fechamento, extrair um aprendizado proporcional e verificável.
- 6. Percorrer o C.O.R.A.G.E.M.[®] e definir uma primeira ação pequena, específica e possível.
- 7. Registrar como a resistência aparece e quais apoios serão necessários.
- 8. Executar, observar consequências e retornar momento a momento.

- 9. Revisar a experiência, reconhecer esforços e ajustar o próximo passo.

O ciclo não termina na execução. Toda ação produz nova informação. Essa informação retorna ao corpo, ao remapeamento, à reflexão e ao planejamento seguinte.

15.11 Prontidão Somatopsíquica nos Seis Pilares da Medicina do Estilo de Vida

A Medicina do Estilo de Vida organiza a prática em seis pilares: nutrição, atividade física, manejo do estresse, controle ou evitação de substâncias de risco, sono adequado e Conexões. O American College of Lifestyle Medicine atualizou o antigo pilar de conexão social para uma formulação mais ampla de connectedness, aqui apresentada como Conexões. Esses pilares descrevem grandes domínios de cuidado; dentro de cada um deles existem diferentes comportamentos possíveis, indicações clínicas e barreiras à mudança.

O pilar Conexões não se limita aos relacionamentos entre pessoas. Ele pode incluir vínculos humanos, convivência com animais de companhia, contato com a natureza, pertencimento, comunidade, espiritualidade, valores, sentido e propósito. A relevância de cada dimensão deve ser reconhecida pela própria pessoa, sem impor crenças, relações ou formas predeterminadas de conexão.

A IPS® não substitui a avaliação nem a prescrição próprias de cada pilar. Sua contribuição está em trabalhar a prontidão somatopsíquica para que a recomendação possa ser percebida, relacionada a valores, experimentada com agência e transformada em ação sustentável. Os exemplos seguintes mostram esse raciocínio nos seis pilares. Não são prescrições prontas: meta, intensidade e ação devem ser individualizadas conforme condições de saúde, preferências, segurança e realidade da pessoa.

Os seis pilares da Medicina do Estilo de Vida indicam domínios de cuidado. Os quatro pilares da IPS® organizam capacidades que podem apoiar a mudança nesses domínios: consciência corporal, presença-agência, conexão-transcendência e gratidão-celebração.

15.11.1 Pilar do Sono Adequado: Criar uma Transição para o Repouso

Situação: a pessoa deseja dormir mais cedo, mas permanece trabalhando ou usando telas até o momento de deitar. Ao imaginar encerrar as atividades, percebe inquietação no peito e a sensação de que “ainda não fez o suficiente”.

- Nos sete passos — mapear a inquietação e a cobrança; experimentar um gesto de encerramento ou desaceleração; remapear; reconhecer o que a dificuldade de parar revela.

- No C.O.R.A.G.E.M.® — Coração: recuperar energia e saúde; Resistência: medo de perder produtividade; Ação: iniciar um ritual breve e viável de transição; Gentileza: não transformar uma noite difícil em fracasso; Momento a Momento: retomar no dia seguinte.
- Ação verificável — escolher, com a pessoa, um horário e um primeiro comportamento de transição compatível com sua rotina, registrando o que favoreceu ou dificultou sua realização.

15.11.2 Pilar da Atividade Física: Sair do Tudo ou Nada

Situação: a pessoa acredita que somente um treino longo “conta”. Quando pensa em começar, sente peso no corpo, vergonha por estar sedentária e antecipação de fracasso.

- Nos sete passos — mapear peso, retraimento e vergonha; permitir um movimento corporal tolerável; remapear a experiência e reconhecer se algum grau de vitalidade, desconforto ou capacidade apareceu.
- No C.O.R.A.G.E.M.® — Coração: mobilidade, autonomia ou disposição; Resistência: comparação e pensamento tudo ou nada; Ação: escolher uma prática pequena e segura; Gentileza: reconhecer o ponto de partida real; Emergir: descobrir uma forma de movimento que seja autêntica.
- Ação verificável — definir quando, onde, por quanto tempo e com qual apoio a primeira experiência de movimento ocorrerá, respeitando avaliação médica quando indicada.

15.11.3 Pilar da Nutrição e Dieta Adequadas: Ampliar Escolha sem Moralização

Situação: a pessoa deseja melhorar a alimentação, mas alterna restrição rígida e episódios de comer automaticamente. Antes de uma refeição difícil, percebe urgência, vazio, tensão ou desconexão dos sinais de fome e saciedade.

- Nos sete passos — realizar grounding; mapear sinais corporais, emoção e contexto; experimentar uma resposta regulatória possível; remapear antes de decidir como proceder.
- No C.O.R.A.G.E.M.® — Coração: cuidado, energia ou relação mais pacífica com a comida; Resistência: regras rígidas, pressa, vergonha ou ambiente; Ação: escolher uma mudança alimentar específica e possível; Gentileza: evitar punição após dificuldades.
- Ação verificável — pode envolver organizar uma refeição, incluir um alimento acordado, sentar-se para comer ou reduzir uma barreira prática, conforme avaliação médica e nutricional.

Em transtornos alimentares, perda de controle recorrente, restrição importante ou risco clínico, a IPS® deve integrar-se ao acompanhamento especializado. Consciência corporal não substitui plano alimentar nem tratamento multiprofissional.

15.11.4 Pilar do Manejo do Estresse: Transformar Sinal em Limite ou Recurso

Situação: a pessoa reconhece tensão apenas quando já está exausta. Durante o trabalho, normaliza respiração presa, mandíbula contraída e ausência de pausas.

- Nos sete passos — mapear sinais precoces; experimentar grounding, movimento, som ou outro recurso; remapear e identificar qual necessidade ficou mais clara.
- No C.O.R.A.G.E.M.® — Coração: preservar saúde e qualidade de presença; Resistência: culpa por pausar ou medo de julgamento; Ação: inserir uma pausa possível ou comunicar um limite; Oração/conexão: lembrar valores que orientam o cuidado.
- Ação verificável — combinar um sinal que funcionará como lembrete, uma resposta breve e o modo de avaliar se houve algum efeito, sem usar autorregulação para sustentar condições insustentáveis.

15.11.5 Pilar do Controle de Substâncias Tóxicas: Álcool, Tabaco e Outros Comportamentos de Alívio

Situação: a pessoa utiliza álcool, tabaco ou outro comportamento para desacelerar, aliviar tensão, socializar ou evitar estados internos. Ao imaginar reduzir, percebe ansiedade, irritação, medo de abstinência ou perda de pertencimento.

- Nos sete passos — explorar com segurança a função do comportamento e sua expressão corporal, sem exposição desnecessária nem indução de abstinência durante a prática.
- No C.O.R.A.G.E.M.® — Coração: saúde, autonomia ou relações; Resistência: craving, rotina, medo e contexto social; Ação: procurar avaliação, acionar apoio ou executar o primeiro passo do plano terapêutico; Gentileza: compreender recaída como dado clínico, não falha moral.
- Ação verificável — deve ser definida conforme substância, padrão de uso, risco de abstinência e tratamento indicado. Em dependência ou risco clínico, encaminhamento e acompanhamento especializado são prioritários.

15.11.6 Pilar das Conexões: Ampliar Vínculo, Pertencimento e Sentido

Situação: a pessoa percebe desconexão, solidão ou perda de sentido, mas a aproximação pode ser dificultada por exaustão, vergonha, medo de rejeição, experiências relacionais anteriores ou ausência de espaços seguros. Ao imaginar conectar-se, percebe retraimento, congelamento ou desejo de aproximação.

- Nos sete passos — mapear no corpo aproximação, proteção, pertencimento ou desconexão; experimentar um gesto de limite, abertura, alcance ou contato; remapear e acolher o grau e a forma de conexão toleráveis.
- No C.O.R.A.G.E.M.® — Coração: reconhecer que vínculo, valor ou sentido importa; Oração/conexão: aproximar-se do que transcende o eu habitual; Resistência: observar medo, descrença ou retraimento; Ação: escolher uma forma autêntica e proporcional de conexão; Momento a Momento: permitir que ela seja construída gradualmente.
- Ação verificável — pode incluir procurar uma pessoa segura, conviver com um animal de companhia, estar na natureza, participar de uma comunidade, cultivar silêncio ou espiritualidade, retomar uma prática orientada por valores ou realizar uma ação que expresse sentido e propósito.

Conexão não significa exposição indiscriminada nem obrigação de sociabilidade. Limites, segurança e consentimento também fazem parte de vínculos saudáveis. Animais, natureza e espiritualidade podem ser recursos importantes, mas não substituem cuidado clínico, apoio humano ou mudanças contextuais quando estes são necessários.

15.12 O Padrão Comum aos Exemplos

Apesar das diferenças entre os hábitos, o raciocínio clínico se repete:

- Começar por uma mudança específica, e não por “mudar de vida”.
- Perguntar como a intenção e a resistência aparecem no corpo, nas emoções e no contexto.
- Relacionar a mudança a um valor que pertença à pessoa.
- Experimentar agência antes de exigir desempenho.
- Remapear para reconhecer efeitos reais, ausência de efeito e limites.
- Definir uma ação pequena, situada, observável e segura.
- Antecipar barreiras, recursos e apoios.

- Revisar o resultado com curiosidade e ajustar o próximo passo.

Na Medicina do Estilo de Vida, cada pilar reúne comportamentos terapêuticos possíveis. A prontidão somatopsíquica investiga e fortalece as condições internas, relacionais e ambientais que permitem que esses comportamentos comecem a existir e possam ser sustentados.

15.13 Avaliação Clínica da Prontidão

A avaliação deve ser conversacional, contextual e específica para a mudança escolhida. Perguntas úteis incluem:

- O que você deseja mudar, concretamente?
- Por que essa mudança importa para você — e não apenas para outras pessoas?
- O que acontece em seu corpo quando imagina realizar esse passo?
- Que parte se aproxima e que parte recua?
- Qual é o medo, custo ou perda possível envolvido?
- Que recursos internos, relacionais e ambientais estão disponíveis?
- Qual seria uma ação pequena o suficiente para ser possível e significativa o suficiente para valer a pena?
- Como saberemos que essa ação aconteceu e que efeito produziu?

O aplicador não atribui um rótulo global de “pronto” ou “não pronto”. Ele identifica a prontidão para uma ação específica e o componente que necessita de apoio.

15.14 Transformando Insight em Ação

O fechamento precisa evitar dois extremos: terminar em compreensão abstrata ou transformar imediatamente qualquer insight em uma decisão ampla. A passagem segura para a ação exige realidade concreta.

- Especificidade — o que exatamente será feito?
- Proporção — o passo cabe nos recursos atuais?
- Contexto — onde, quando e com quem ocorrerá?
- Apoio — quem ou o que pode sustentar a ação?

- Observabilidade — como a pessoa reconhecerá que agiu e qual efeito ocorreu?
- Flexibilidade — o que poderá ser ajustado se houver dificuldade?

Planos situacionais podem ajudar a reduzir a distância entre intenção e comportamento: “Se determinada situação ocorrer, então realizarei a ação combinada”. Eles são recursos de planejamento, não garantias de execução.

15.15 Quando a Ação não Acontece

Uma ação não realizada não deve encerrar o processo com “faltou força de vontade”. O aplicador retorna com curiosidade ao ciclo: o passo era grande? A resistência foi reconhecida? O valor era realmente da pessoa? Faltou apoio, tempo, segurança, recurso ou oportunidade? Houve sofrimento clínico ou barreira estrutural?

A revisão pode produzir diferentes decisões: reduzir o passo, modificar o contexto, buscar suporte, ensaiar novamente no corpo, escolher outra estratégia, adiar conscientemente ou reconhecer que aquela meta não é autêntica. Aprender com o não realizado também pode fortalecer agência.

15.16 Gentileza, Celebração e Manutenção

Gentileza protege a mudança contra o ciclo de cobrança, vergonha e abandono. Celebração ajuda a marcar experiências reais de esforço, presença, aprendizagem e ação. Nenhuma delas significa diminuir responsabilidade ou elogiar resultados inexistentes.

No modo gratidão–celebração, a pessoa pode reconhecer apoio recebido, capacidade que emergiu e passos já realizados. A celebração corporificada transforma um acontecimento positivo em experiência percebida, favorecendo memória do recurso e continuidade do percurso.

15.17 Prontidão não é Responsabilidade Isolada

Comportamentos acontecem em sistemas. Condições econômicas, trabalho, família, acesso, discriminação, doença, ambiente e políticas podem facilitar ou impedir uma mudança. A pessoa não deve ser responsabilizada por barreiras que não controla.

A agência somatopsíquica inclui discriminar o que depende da pessoa, o que depende das relações e o que exige mudança institucional. Às vezes, a ação mais coerente é pedir ajuda, negociar, criar apoio, interromper uma exposição, buscar tratamento ou defender uma transformação do ambiente.

15.18 Cuidados e Erros Comuns

- Tratar prontidão somatopsíquica como escala, diagnóstico ou estágio validado.
- Confundir informação, intenção ou motivação verbal com disponibilidade para agir.
- Forçar os sete passos quando falta segurança ou estabilidade.
- Interpretar resistência como preguiça, oposição ou falha moral.
- Transformar o C.O.R.A.G.E.M.[®] em checklist mecânico ou cobrança por desempenho.
- Usar transcendência para impor crenças religiosas ou desconsiderar a realidade concreta.
- Celebrar de forma artificial, apagando sofrimento, barreiras ou resultados que não ocorreram.
- Generalizar uma mudança corporal para a crença de que a pessoa pode controlar qualquer resultado.
- Definir ações grandes, vagas ou dependentes de condições inexistentes.
- Ignorar barreiras relacionais, sociais e estruturais.

15.19 Do Artigo ao Consultório

- Avalie a prontidão para uma mudança específica, não como característica global da pessoa.
- Explore a distância entre intenção e ação sem produzir culpa.
- Use os sete passos para construir contato, segurança, agência e integração.
- Use o remapeamento para reconhecer efeitos reais e limites, sem sugerir melhora obrigatória.
- No fechamento, converta aprendizado em ação pequena, observável e ajustável.
- Utilize o C.O.R.A.G.E.M.[®] para sustentar valor, atravessar resistência e acompanhar o processo momento a momento.
- Integre autoeficácia, apoio e condições ambientais ao plano.
- Reconheça ação, aprendizagem e pedido de ajuda como formas possíveis de agência.

Considerações Finais

A prontidão somatopsíquica para mudança expressa uma contribuição central da IPS[®]: antes de exigir comportamento, ajudar a pessoa a tornar-se disponível para uma ação que possa reconhecer como sua, sustentar no corpo e realizar no mundo.

Os sete passos constroem uma travessia da presença à integração. O C.O.R.A.G.E.M.® sustenta a passagem do que foi percebido para o que será vivido. Juntos, eles organizam um ciclo no qual a pessoa pode reconhecer o que importa, acolher a resistência, experimentar agência, observar efeitos, agir com gentileza e continuar momento a momento.

Mudança sustentável não é um salto entre saber e fazer. É um percurso corporificado entre perceber, significar, escolher, agir, remapear, aprender e recomeçar.

15.20 Da Percepção à Transformação

Ao longo deste manual, a IPS® foi apresentada como uma intervenção que parte da experiência vivida e retorna à vida prática. A percepção corporal constitui uma porta de entrada, mas não é o ponto de chegada. Perceber torna-se clinicamente relevante quando amplia presença, favorece escolha, mobiliza agência, reconhece conexão e sentido e permite que a pessoa participe de mudanças possíveis em sua realidade.

Esse percurso não é linear nem obrigatório. Em alguns momentos, transformar significará realizar uma ação concreta. Em outros, poderá significar reconhecer um limite, pedir ajuda, sustentar uma pausa, reformular uma meta, proteger-se, aproximar-se de um vínculo ou permanecer com segurança diante da experiência. A qualidade da transformação não é medida por intensidade, rapidez ou desempenho, mas pela coerência entre experiência, necessidade, contexto e ação possível.

Os quatro pilares oferecem sustentação a esse movimento: a consciência corporal torna a experiência perceptível; a presença-agência abre espaço para participação e resposta; a conexão-transcendência relaciona o percurso a vínculos, valores, sentido e propósito; e a gratidão-celebração reconhece recursos, aprendizados e passos reais. Os sete passos organizam a experiência clínica, enquanto o C.O.R.A.G.E.M.® favorece sua continuidade no cotidiano.

Na IPS®, transformação não significa obrigar o corpo a confirmar uma ideia. Significa escutar a experiência, experimentar uma resposta, reconhecer seus efeitos e levar para a vida um aprendizado possível, situado e autêntico.

Fontes Utilizadas Neste Capítulo

Material da mentoria: CORAGEM. Documento de autoria da Dra. Renata Fário Guerra. A sequência, os significados das letras, as perguntas e a proposta de registro foram preservados conforme o material fornecido.

Guerra, R. F.; Tavares, H. (2025). Theory and conception of Somatopsyche Psychiatric Intervention: a transdiagnostic body-mind intervention for psychiatric practice. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1644739. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2025.1644739>

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *American Psychologist*, 44(9), 1175-1184. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.9.1175>

Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. *Health Education & Behavior*, 31(2), 143-164. <https://doi.org/10.1177/1090198104263660>

Webb, T. L.; Sheeran, P. (2006). Does changing behavioral intentions engender behavior change? A meta-analysis of the experimental evidence. *Psychological Bulletin*, 132(2), 249-268. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.2.249>

Zhang, C.-Q.; Zhang, R.; Schwarzer, R.; Hagger, M. S. (2019). A meta-analysis of the Health Action Process Approach. *Health Psychology*, 38(7), 623-637. <https://doi.org/10.1037/hea0000728>

Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Portal de Publicações do CBMEV. Seis pilares da Medicina do Estilo de Vida. <https://publicacoes.cbmev.org.br>

American College of Lifestyle Medicine. Pillar updates: stress management and social connection. Atualização do pilar social connection para connectedness, incluindo relações horizontais e verticais associadas a significado e propósito. 2025. <https://lifestylemedicine.org/pillar-updates-stress-management-and-social-connection/>

CONCLUSÃO DO MANUAL

UMA PRÁTICA CORPORIFICADA, ÉTICA E EM CONSTRUÇÃO

Síntese e Continuidade da Formação em Psiquiatria Somatopsíquica

Este Manual do Aplicador reuniu os fundamentos conceituais, os pilares, a arquitetura experiencial, os instrumentos de avaliação e as orientações gerais para aplicação clínica da Intervenção em Psiquiatria Somatopsíquica. Seu propósito é oferecer ao profissional uma base organizada para compreender o método, preparar a prática e conduzi-la com presença, responsabilidade e respeito à singularidade de cada pessoa.

A IPS® não se reduz à execução de uma sequência. Sua qualidade depende da capacidade do aplicador de reconhecer segurança, ritmo, consentimento, proximidade com o corpo, contexto clínico e momento de cada participante. Grounding, mapeamento, agência, remapeamento, insight, atenção plena e fechamento tornam-se terapêuticos quando utilizados com flexibilidade, critério e escuta — e não como etapas a serem cumpridas a qualquer custo.

Ao concluir este manual, o aplicador deve conservar uma orientação central: a experiência da pessoa vem antes da técnica. O método oferece um caminho; a clínica determina como, quando e até onde percorrê-lo. Quando houver insegurança, desorganização ou desconforto, cabe reduzir a intensidade, retornar ao grounding, ampliar suporte, interromper a prática ou buscar o cuidado indicado.

O Lugar deste Manual

Este volume encerra-se com Mudança de Hábitos e Medicina do Estilo de Vida porque esse tema integra o percurso formativo: da percepção corporal à presença, da presença à agência e da experiência à mudança possível. Assim, o manual permanece dedicado ao núcleo estrutural e transversal da IPS®, sem acumular funções que exigem materiais próprios.

Documentos Complementares

Os conteúdos operacionais e as aplicações que necessitam de maior detalhamento serão organizados separadamente. Essa arquitetura permitirá aprofundar, revisar e atualizar cada material sem alterar desnecessariamente o núcleo do manual.

- Protocolo completo da IPS® — sequência operacional, orientações de condução, linguagem do aplicador, adaptações e registros da intervenção.
- Cadernos de aplicação clínica — aprofundamentos para ansiedade, depressão, transtornos alimentares, burnout e outras condições, sempre delimitando evidência, hipótese clínica e papel complementar da IPS®.
- Caderno de escalas e instrumentos — versões autorizadas, finalidade, aplicação, correção, interpretação e limites de uso de cada medida.
- Material do participante ou paciente — práticas, registros, exercícios e recursos redigidos para quem recebe a intervenção.
- Manual de situações clínicas complexas — manejo de dificuldades, interrupções, instabilidade e decisões de encaminhamento, a ser desenvolvido quando houver base suficientemente estruturada e validada.

Esses documentos não substituem formação, supervisão, julgamento clínico, avaliação diagnóstica ou tratamentos indicados. Eles ampliarão a aplicação do método mantendo a mesma exigência de clareza conceitual, prudência clínica e fidelidade às fontes da formação.

Uma Formação que Continua

Encerrar este manual não significa encerrar a construção da Psiquiatria Somatopsíquica. A IPS® permanece comprometida com estudo, prática supervisionada, investigação científica e revisão responsável de seus materiais. Novas aplicações deverão ser incorporadas apenas quando puderem ser distinguidas com clareza entre fundamento teórico, evidência disponível, formulação própria da IPS® e experiência clínica ainda em desenvolvimento.

Que este manual ajude o aplicador a oferecer uma prática na qual o corpo possa ser percebido sem invasão, a presença possa ser cultivada sem exigência, a agência possa emergir sem culpa e a transformação possa acontecer no ritmo possível de cada pessoa.

Perceber. Estar presente. Experimentar agência. Reconhecer conexão e sentido. Integrar o aprendizado. Levar para a vida. Esse é o percurso que este manual convida o aplicador a sustentar.